

PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE & MALADIES INFECTIEUSES

Fiches QE Haute Fréquence – 650 questions d'examen croisées au programme S5 – Version 1

Cross-match : 650 QEs officielles (2019→2026) × Cours AIO FMPM (Parasitologie-Mycologie + Maladies Infectieuses)

Module S5 – Parasitologie-Mycologie & Maladies Infectieuses – FMPM Marrakech 2026

PARTIE 1 – CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 650 QEs (13 sessions).

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	Paludisme	45 Q	–
2	Méningites (purulentes & LCS clair)	43 Q	–
3	Mycoses à champignons filamenteux	33 Q	–
4	Nématodes : oxyure, trichocéphale, ascaris	33 Q	–
5	Infection par le VIH	31 Q	–
6	Leishmanioses	27 Q	–
7	Levures et levuroses	25 Q	–
8	Amibes et amibiases	24 Q	–
9	Leptospiroses	24 Q	–
10	Rickettsioses – fièvre Q	24 Q	–
11	Le tétanos	23 Q	–
12	La rage humaine	22 Q	–
13	Accidents d'exposition au sang	21 Q	–
14	Toxoplasmoses	20 Q	–
15	Flagelloses digestives et urogénitales	18 Q	–
16	Cestodes : taeniasis & cysticercose	15 Q	–
17	Toxi-infections alimentaires collectives	15 Q	–
18	Fièvres typhoïdes	14 Q	–
19	Protozooses intestinales opportunistes	13 Q	–
20	Échinococcoses humaines	12 Q	–
21	Généralités parasito-mycologie & diagnostic	12 Q	–

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
22	Infections associées aux soins	12 Q	—
23	Bilharzioses	11 Q	—
24	Méningo-encéphalites herpétiques	10 Q	—
25	Nématodes : trichine, ankylostomes, anguillules	10 Q	—
26	Le choléra	10 Q	—
27	La brucellose	9 Q	—
28	Fièvres persistantes	9 Q	—
29	Covid-19	9 Q	—
30	Borrélioses	8 Q	—
31	Syndromes de larva migrans & nématodes tissulaires	7 Q	—
32	Entomologie médicale & ectoparasitoses	6 Q	—
33	Trypanosomiasés	6 Q	—
34	Infections à staphylocoques	5 Q	—
35	Trématodes – distomatoses	1 Q	—
36	Synthèse transversale (tri / transmission)	43 Q (transv.)	—

PARTIE 2 – MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 13 sessions, chaque examen ~50 questions.

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'examen
Paludisme	45	3.46	6.9%
Méningites (purulentes & LCS clair)	43	3.31	6.6%
Mycoses à champignons filamenteux	33	2.54	5.1%
Nématodes : oxyure, trichocéphale, ascaris	33	2.54	5.1%
Infection par le VIH	31	2.38	4.8%
Leishmanioses	27	2.08	4.2%
Levures et levuroses	25	1.92	3.8%
Amibes et amibiases	24	1.85	3.7%
Leptospiroses	24	1.85	3.7%
Rickettsioses – fièvre Q	24	1.85	3.7%
Le tétanos	23	1.77	3.5%
La rage humaine	22	1.69	3.4%
Accidents d'exposition au sang	21	1.62	3.2%
Toxoplasmoses	20	1.54	3.1%
Flagelloses digestives et urogénitales	18	1.38	2.8%
Cestodes : taeniasis & cysticercose	15	1.15	2.3%
Toxi-infections alimentaires collectives	15	1.15	2.3%
Fièvres typhoïdes	14	1.08	2.2%
Protozooses intestinales opportunistes	13	1.00	2.0%
Échinococcoses humaines	12	0.92	1.8%
Généralités parasito-mycologie & diagnostic	12	0.92	1.8%
Infections associées aux soins	12	0.92	1.8%
Bilharzioses	11	0.85	1.7%
Méningo-encéphalites herpétiques	10	0.77	1.5%
Nématodes : trichine, ankylostomes, anguillules	10	0.77	1.5%
Le choléra	10	0.77	1.5%
La brucellose	9	0.69	1.4%
Fièvres persistantes	9	0.69	1.4%

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'exam
Covid-19	9	0.69	1.4%
Borrélioses	8	0.62	1.2%
Syndromes de larva migrans & nématodes tissulaires	7	0.54	1.1%
Entomologie médicale & ectoparasitoses	6	0.46	0.9%
Trypanosomiasés	6	0.46	0.9%
Infections à staphylocoques	5	0.38	0.8%
Trématodes – distomatoses	1	0.08	0.2%
Synthèse transversale (tri / transmission)	43	3.31	6.6%
TOTAL – 36 leçons (toutes au programme)	650 Q	50.0	100%

PARTIE 3 – QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (▲) / source (📖) / lien cours (🔗) / citations (📄)

[RANG 1] PALUDISME (MALARIA)

– • ~3.46 Q/examen

📖 Critères de gravité OMS du paludisme grave

Diagnostic biologique de l'accès palustre – URGENCE (thème le + répété, ~15×) :

- À évoquer devant TOUTE fièvre au retour d'une zone d'endémie impaludée (urgence diagnostique et thérapeutique)
- Examen de référence = frottis sanguin MINCE + goutte épaisse (GE). Frottis = identification d'espèce + parasitémie ; GE = méthode de CONCENTRATION (plus sensible)
- TDR (test de diagnostic rapide) = recherche d'ANTIGÈNES spécifiques de Plasmodium (HRP-2, pLDH)
- Résultat de l'analyse parasitologique rendu en MOINS DE 2 HEURES
- Aucun élément clinique ne permet d'EXCLURE un paludisme au retour de zone d'endémie – même sous chimioprophylaxie
- ▲ FAUX : sérologie / recherche d'anticorps anti-Plasmodium = PAS le diagnostic de 1^{re} intention (piège A/B répété)
- ▲ FAUX : recherche sur biopsie de foie / rate / moelle osseuse
- ▲ FAUX : « résultat rendu en moins de 24 h » – c'est < 2 h
- ▲ FAUX : « suspecter devant fièvre chez un immunodéprimé » – le critère est le RETOUR de zone d'endémie (piège A récurrent)

📖 Vu : 2019N Q32, 2019R Q33, 2020N Q31, 2021N Q11, 2022N Q11, 2024N Q1/Q37, 2024R Q22/Q37, 2025 Q10, 2024Exc Q10/Q37 (~15×)

Cycle de Plasmodium falciparum chez l'Homme (~7×) :

- Transmission par piqûre INDOLORE de l'ANOPHÈLE femelle (vecteur), à la tombée de la nuit
- Multiplication asexuée par SCHIZOGONIE érythrocytaire, durée 48 h (fièvre tierce)
- Gamétocytes formés chez l'Homme (hôte intermédiaire) → gamètes/reproduction sexuée chez le moustique (hôte définitif)
- Phase aquatique nécessaire à la multiplication du vecteur (gîtes larvaires)
- Falciparum : cytoadhérence → obstruction des capillaires cérébraux + lyse des hématies
- ▲ FAUX : vecteur = phlébotome (= Leishmania ! piège A très récurrent) – c'est l'anophèle
- ▲ FAUX : piqûre DOULOUREUSE – elle est indolore
- ▲ FAUX : gamétocytes dans les leucocytes – ils sont dans les hématies
- ▲ FAUX : hypnozoïtes hépatiques pour FALCIPARUM – les hypnozoïtes (rechutes) = P. VIVAX & P. OVALE uniquement (piège C/D récurrent)
- ▲ FAUX : passage dans le LCR / élimination dans selles ou urines

- **▲ Clé discutable :** « gamétocytes chez l'hôte intermédiaire » comptée FAUSSE en 2020R Q6 mais VRAIE en 2021N Q49 – la biologie correcte = VRAIE (gamétocytes chez l'Homme)

📖 Vu : 2019R Q32, 2020R Q6, 2021N Q49, 2021R Q31, 2024N Q36, 2024R Q36, 2026 Q34 (7×)

Critères de gravité du paludisme (OMS) – accès grave à *P. falciparum* (~8×) :

- Neurologique : trouble de conscience, confusion, SOMNOLENCE, coma (neuropaludisme)
- Insuffisance rénale : créatininémie élevée ($\approx \geq 30\text{--}40 \text{ mg/l}$; $> 265 \mu\text{mol/l}$)
- Acidose métabolique / HYPERLACTATÉMIE
- HYPOGLYCÉMIE (glycémie $\leq 0,40 \text{ g/l}$)
- Ictère clinique ; anémie grave ($\text{Hb} < 7 \text{ g/dl}$) ; hyperparasitémie ($\geq 4 \%$)
- **▲ FAUX critère :** anémie à $\text{Hb } 8\text{--}10 \text{ g/dl}$ – le seuil de gravité est $\text{Hb} < 7 \text{ g/dl}$ (piège A récurrent)
- **▲ FAUX critère :** parasitémie 2-3 % – seuil de gravité $\approx \geq 4 \%$ (piège B récurrent)
- **▲ FAUX critère :** THROMBOPÉNIE – fréquente mais N'EST PAS un critère de gravité OMS (piège E récurrent)
- **▲ FAUX critère :** créatininémie 10 mg/l (= normale) ; diurèse 500 ml/j (oligurie = $< 400 \text{ ml/24h}$) ; HYPERglycémie (c'est l'HYP0glycémie qui est grave)

📖 Vu : 2019N Q10, 2019R Q15, 2020N Q23, 2021N Q12, 2023N Q23, 2024N Q2, 2025 Q33 (7×)

Signes biologiques en faveur (accès non compliqué) :

- Thrombopénie ($30\ 000\text{--}80\ 000/\text{mm}^3$) – signe le plus constant
- Hypcholestérolémie
- Splénomégalie, syndrome pseudo-grippal, fièvre
- **▲ FAUX :** taux de leucocytes « normal » présenté comme évocateur (la leuconeutropénie est plutôt attendue)
- **▲ FAUX :** hypercalcémie ; CRP normale (la CRP est élevée)

📖 Vu : 2021N Q10, 2022N Q35

Traitement :

- Accès SIMPLE (non compliqué) : ACT orale = Artéméter-Luméfantrine (Coartem®)
- Accès GRAVE : ARTÉSUNATE IV en 1^{re} intention (alternative : artéméter IV)
- Suivi parasitologique post-thérapeutique : J3, J7 et J28
- **▲ FAUX traitements (pièges аштуво) :** ceftriaxone/céfotaxime-gentamicine, ciprofloxacine, amoxicilline (= typhoïde/bactérien), azithromycine, Tamiflu® (= grippe)
- **▲ Primaquine** = cure radicale des hypnozoïtes (*P. vivax*/ovale) et gamétocytocide – PAS le traitement de l'accès à *falciparum*
- **▲ FAUX suivi :** J10, J21

📖 Vu : 2020R Q39, 2021N Q13/Q14, 2021R Q3

Épidémiologie & prophylaxie :

- Réservoir HUMAIN sauf *P. knowlesi* (réservoir = singe macaque)
- Transmission possible aussi par TRANSFUSION (paludisme transfusionnel) et voie transplacentaire

- Prévention : chimioprophylaxie adaptée, moustiquaires imprégnées, vêtements longs à la tombée de la nuit, + VACCINATION (RTS,S/R21) ; déconseiller le voyage en zone d'endémie aux enfants et femmes enceintes
- ⚠ FAUX : « la transfusion ne transmet pas » ; « s'éloigner des chats errants » (= piège toxoplasmose)

📖 Vu : 2022N Q34, 2023N Q34, 2026 Q34

[RANG 2] MÉNINGITES INFECTIEUSES DE L'ADULTE

– • ~3.31 Q/examen

📖 Profils du LCR par étiologie (clair vs purulent / glycorachie / cellularité)

Lecture du LCR – la clé du sujet (~12×) – méningite à liquide CLAIR + HYP0glycorachie + hyperprotéinorachie + lymphocytes :

- Ce profil (clair, lymphocytaire, hypoglycorachique, hyperprotéinorachique) oriente vers 2 diagnostics : MÉNINGO-ENCÉPHALITE TUBERCULEUSE et CRYPTOCOCCOSE neuro-méningée (terrain VIH)
- Examen sanguin OBLIGATOIRE pour interpréter toute PL = la GLYCÉMIE (calcul du rapport glycorachie/glycémie ; hypoglycorachie si rapport < 0,5)
- LCR purulent (trouble) + PNN + hypoglycorachie + germe à l'examen direct → méningite BACTÉRIENNE
- Hyperalbuminorachie = protéinorachie > 0,4 g/l ; hypoglycorachie = glycorachie < 50 % de la glycémie
- ⚠ FAUX : glycorachie « normale » dans la tuberculose ou la cryptococcose (elle est BASSE)
- ⚠ FAUX : LCR « normal » devant 100-600 éléments lymphocytaires avec hyperprotéinorachie

📖 Vu : 2020N Q11, 2021N Q3/Q4, 2023N Q14, 2024R Q3, 2024Exc Q20-22 (~12×)

Méningo-encéphalite TUBERCULEUSE :

- Installation SUBAIGUË/CHRONIQUE sur plusieurs semaines à mois ; fièvre quasi constante ; troubles visuels fréquents ; PARALYSIE des nerfs oculomoteurs (atteinte des paires crâniennes)
- Rechercher une localisation tuberculeuse extra-neurologique ; TOUJOURS dépister le VIH
- LCR : clair, lymphocytaire, hypoglycorachie, hyperprotéinorachie (souvent > 1 g/l), HYPOCHLORURACHIE, HYPONATRÉMIE (SIADH)
- Diagnostic : Gene Xpert MTB/RIF, coloration de Ziehl-Neelsen, culture sur milieu de Löwenstein-Jensen (dans le LCR)
- Traitement : antibacillaires 9-12 mois + CORTICOTHÉRAPIE ; imagerie (IRM) avant la PL si signes de focalisation/HTIC
- ⚠ FAUX : installation AIGUË (piège A très récurrent) – c'est subaigu/chronique
- ⚠ FAUX : prédominance des POLYNUCLÉAIRES ; glycorachie/albuminorachie normales (0,4 g/l) ; natrémie normale
- ⚠ FAUX : antibacillaires pour 6 mois – la méningite TB se traite 9-12 mois

📖 Vu : 2019N Q16/Q17, 2019R Q6/Q7/Q36, 2020N Q11/Q12, 2021N Q1/Q2, 2021R Q21, 2024Exc Q21-23 (~12×)

CRYPTOCOCCOSE neuro-méningée (Cryptococcus neoformans) :

- Terrain : immunodépression, surtout VIH/SIDA (pathologie classante = stade C de la classification CDC)
- LCR clair lymphocytaire hypoglycorachique ; coloration à l'ENCRE DE CHINE positive (met en évidence la capsule)
- Conduite : quantifier les CD4, dépister le VIH (et chez le/la partenaire), déclarer le VIH, traiter (amphotéricine B + flucytosine puis fluconazole)
- **▲ FAUX : annoncer la séropositivité VIH à toute la famille (confidentialité) ; un VIH avec cryptococcose neuro-méningée = stade C (SIDA), pas stade A ou B**

📖 Vu : 2020N Q11/Q12, 2021N Q5, 2023N Q15, 2024R Q3/Q4

Méningite à MÉNINGOCOQUE (Neisseria meningitidis) :

- COCCI GRAM NÉGATIF (en diplocoque) à l'examen direct / hémocultures
- Prédominance automne-hiver ; épidémies possibles ; maladie à DÉCLARATION obligatoire
- Purpura possible → PURPURA FULMINANS (purpura nécrotique extensif, urgence vitale, risque d'amputation des extrémités)
- Chimio prophylaxie des sujets contacts dans les 48 h : RIFAMPICINE 600 mg ×2/j × 2 jours (alternative : Spiramycine 3 MUI ×2/j × 5 j) + vaccination (pèlerins, sérogroupes A/C/W/Y)
- **▲ FAUX : cocci Gram POSITIF (= pneumocoque) ; cocci Gram positif aux hémocultures**
- **▲ FAUX : séro groupe B « rare au Maroc » ; vaccination « seulement A et C »**
- **▲ FAUX : déclencher des cyclines/doxycycline devant un purpura fulminans (c'est la ceftriaxone)**

📖 Vu : 2019N Q15, 2019R Q8, 2021N Q6/Q7, 2023N Q21, 2024R Q1, 2025 Q50, 2026 Q19/Q20

Purpura fulminans – URGENCE pré-hospitalière :

- Complique une méningococcémie ; purpura nécrotique extensif ; PEC commencée AVANT l'hospitalisation
- Injection IMMÉDIATE de CEFTRIAXONE (ou céfotaxime) IV/IM en pré-hospitalier, puis transfert urgent
- Peut aboutir à la nécrose des extrémités → amputation
- **▲ FAUX : doxycycline, ciprofloxacine, rifampicine ou métronidazole en urgence – c'est la ceftriaxone/céfotaxime**

📖 Vu : 2020R Q34, 2021N Q6/Q7, 2026 Q19

Méningite à PNEUMOCOQUE (Streptococcus pneumoniae) :

- COCCI GRAM POSITIF ; porte d'entrée ORL (complique une OTITE, sinusite) ou brèche ostéo-méningée (ATCD trauma crânien)
- ATCD de méningite purulente récidivante = évocateur (brèche) ; signes de FOCALISATION neurologique fréquents
- Traitement : CEFTRIAXONE / céfotaxime IV (forte dose)
- **▲ FAUX : transmission par voie digestive ; amoxicilline-acide clavulanique en 1^{re} intention**
- **▲ FAUX : prophylaxie systématique des sujets contacts (c'est pour le méningocoque, pas le pneumocoque)**

📖 Vu : 2020R Q32/Q33, 2021R Q20, 2026 Q21

Méningite à LISTERIA monocytogenes :

- BACILLE GRAM POSITIF dans le LCR (signe d'appel) ; terrain : grossesse, sujet âgé, immunodéprimé ; atteinte rhombencéphalique
- **▲ FAUX** : suspectée devant cocci Gram positif, une sinusite, un trauma crânien ou un purpura extensif (= autres germes)

📖 Vu : 2020R Q35

Syndrome méningé clinique & démarche :

- Signes : raideur de nuque, photophobie, céphalées, signe de KERNIG POSITIF, signe de BRUDZINSKI POSITIF
- 1^{er} examen diagnostique = PONCTION LOMBAIRE (sauf signes de focalisation/HTIC/trouble de conscience → imagerie d'abord)
- Pas de PL de contrôle en fin de traitement si bonne évolution (méningocoque/pneumocoque)
- **▲ FAUX** : le signe de Brudzinski NÉGATIF présenté comme un signe de syndrome méningé (c'est le signe POSITIF qui compte)

📖 Vu : 2020R Q29/Q30/Q31

[RANG 3] MYCOSES À CHAMPIGNONS FILAMENTEUX

– • ~2.54 Q/examen

Dermatophytes – définition & généralités (~10×) :

- 3 genres : MICROSPORUM, TRICHOPHYTON, EPIDERMOPHYTON
- Champignons FILAMENTEUX microscopiques à mycélium CLOISONNÉ, KÉRATINOPHILES et kératinolytiques (peau, poils, ongles)
- Origine anthropophile, zoophile (chat = Microsporum canis) ou géophile ; transmission interhumaine ET animale ; chaleur + humidité favorisent
- Tableaux : teignes du cuir chevelu, onychomycose (pieds++), dermatophytose circinée de la peau glabre, intertrigo des plis
- **▲ FAUX** : protozoaires opportunistes ; commensaux du tube digestif (= Candida) ; champignons comestibles ; contamination « toujours animale » ; pathologie « uniquement unguéale »
- **▲ FAUX** (tableaux) : méningite, MUGUET (= Candida), sepsis, kératite
- **▲ FAUX** : diagnostic par SÉROLOGIE (c'est l'examen direct + culture)

📖 Vu : 2021N Q34-36, 2022N Q22, 2024N Q40, 2024R Q48/Q49, 2025 Q24, 2024Exc Q49/Q50 (~10×)

Teignes tondantes du cuir chevelu :

- TRICHOPHYTIQUES (anthropophiles, ex. T. violaceum) : PETITES plaques NOMBREUSES, cheveux coupés courts englués dans les squames, NON fluorescents à Wood, forte contagion interhumaine (épidémies scolaires)
- MICROSPORIQUES (M. canis, zoophile) : GRANDES plaques peu nombreuses, FLUORESCENCE verte à la lumière de WOOD
- Atteignent surtout l'ENFANT ; repousse des cheveux possible (non cicatricielles) ; teigne à petite plaque scolaire → T. violaceum
- **▲ FAUX** (trichophytiques) : lésions peu nombreuses et de grande taille ; Microsporum canis incriminé ; cheveux fluorescents à Wood ; perte définitive des cheveux
- **▲ FAUX** : l'adulte plus touché que l'enfant

📖 Vu : 2019N Q49, 2019R Q45, 2020N Q47, 2020R Q21/Q22, 2021R Q48, 2024N Q49, 2025 Q24

Dermatophytose circinée (peau glabre) & diagnostic mycologique :

- Lésion érythémato-squameuse à bordure ACTIVE, extension CENTRIFUGE, sur peau glabre ; agent fréquent = *Microsporum canis* (peau glabre) ou *T. rubrum* / *Epidermophyton floccosum* (plis)
- Prélèvement diagnostique au POURTOUR/bordure de la lésion ; guérison SANS cicatrice
- Prélèvement : squames, ongles, cheveux/poils ; examen direct (filaments mycéliens) ; culture sur SABOURAUD + antibiotique + CYCLOHEXIMIDE (actidione) ; lumière de Wood contributive
- ⚠ FAUX : cicatrice indélébile ; enduit blanchâtre au fond du pli (= candidose) ; champignon dimorphique ; GLUCANTIM comme traitement (= Leishmaniose)
- ⚠ FAUX (diagnostic) : sérologie ; identification macroscopique seule suffisante ; test de blastèse (= *Candida*) ; délai de pousse uniforme de 5 jours (il est lent et variable)

📖 Vu : 2019R Q47, 2020N Q48, 2020R Q23, 2021R Q47, 2022N Q23, 2023N Q46, 2025 Q25

Trichophyton rubrum & Aspergillus :

- *T. rubrum* (dermatophyte le + fréquent) : kératinophile ; atteinte unguéale au bord DISTAL, onychomycose des pieds ; anthropophile ; sensible à la TERBINAFINE
- *Aspergillus fumigatus* : champignon filamenteux responsable d'INFECTIONS RESPIRATOIRES (aspergilloses), contamination par INHALATION de spores
- ⚠ FAUX (*T. rubrum*) : donne une teigne du cuir chevelu ; mycose profonde ; réservoir = chat ; résistant à la terbinafine ; atteinte unguéale PROXIMALE avec périonyxis (= *Candida*)
- ⚠ FAUX (dermatophytes) : traitement par dermocorticoïde (l'aggrave)

📖 Vu : 2020N Q46, 2021R Q46, 2022N Q20, 2024N Q47

Onychomycoses – distinction dermatophyte vs Candida (high-yield) :

- À DERMATOPHYTES (*T. rubrum*) : débute au bord DISTAL/latéral, surtout ongles des PIEDS, SANS périonyxis
- À CANDIDA : débute par un PÉRIONYXIS, surtout ongles des MAINS
- ⚠ FAUX : onychomycose à dermatophytes uniquement chez l'immunodéprimé ; onychomycose à dermatophytes débutant par un périonyxis

📖 Vu : 2026 Q49

[RANG 4] NÉMATODES : OXYURE, TRICHOCÉPHALE, ASCARIS

– • ~2.54 Q/examen

OXYUROSE (*Enterobius vermicularis*) – le + posé (~16%) :

- Nématode (ver rond) STRICTEMENT HUMAIN, à cycle MONOXÈNE (un seul hôte) ; adultes visibles à l'œil nu
- Symptôme majeur = PRURIT ANAL VESPÉRAL (le soir) ; peut donner une VULVO-VAGINITE chez la fillette, irritabilité, insomnie

- Œufs DIRECTEMENT INFESTANTS (embryonnés dès la ponte) → AUTO-INFESTATION par cycle main-anus-bouche
- Diagnostic = SCOTCH-TEST ANAL de Graham (œufs à la marge anale) ± œufs/adultes dans les selles
- Prophylaxie : traiter TOUTE la fratrie/famille, se laver les mains avant chaque repas, couper les ongles courts, RENOUELER le traitement 2-3 semaines après (auto-infestation)
- ▲ FAUX : oxyure = cestode/trématode/ver plat – c'est un NÉMATODE (piège récurrent)
- ▲ FAUX : forte éosinophilie (pas de migration tissulaire → éosinophilie faible) ; femelle parthénogénétique (= anguillule)
- ▲ FAUX : transmis par voie transcutanée active / par un vecteur – c'est la voie ORALE (œufs)
- ▲ FAUX : atteinte cérébrale/respiratoire ; œufs operculés ; vivipare ; cause de TIAC
- ▲ FAUX traitement : fluconazole (= antifongique) ; pommade ; cure unique de 15 j ; traiter les animaux (ver strictement humain)

📖 Vu : 2019R Q40, 2021N Q38, 2021R Q36/Q37, 2023N Q42, 2024N Q41, 2024R Q43/Q44, 2025 Q11/Q12, 2026 Q36/Q37/Q38 (≈16×)

ASCARIDIOSE (Ascaris lumbricoides) – très répété (~11×) :

- Nématode (ver rond) d'environ 20 cm ; transmission par voie ORALE (œufs embryonnés, péril fécal) ; cycle MONOXÈNE
- Migration larvaire trans-pulmonaire (cycle de Læss) : la larve traverse le POUMON avant de regagner l'intestin
- Phase de migration → syndrome de LËFFLER (infiltrat pulmonaire labile + toux + HYPERÉOSINOPHILIE)
- Complication = OCCLUSION INTESTINALE (paquet de vers) ; diagnostic = œufs MAMELONNÉS dans les selles + émission de vers ronds blanc-rosés
- ▲ FAUX : ver plat / plathelminthe / rubané / cestode de 10 m (= taenia) – c'est un nématode rond
- ▲ FAUX : persiste par AUTO-INFESTATION (c'est l'oxyure/l'anguillule, PAS l'ascaris – piège D très récurrent)
- ▲ FAUX : œufs en forme de citron (= trichocéphale) ; cycle hétéroxène ; transmission transcutanée ; zoonose/contact chien
- ▲ FAUX : diagnostic dans les urines ; recherche de LARVES dans les selles (ce sont les ŒUFS) ; envahit le SNC ; hépatomégalie/thrombopénie/lymphopénie/endocardite

📖 Vu : 2019N Q40, 2019R Q41, 2020R Q14, 2021N Q41, 2021R Q35, 2022N Q14, 2024N Q42, 2025 Q14, 2026 Q39/Q40 (≈11×)

TRICHOCÉPHALOSE (Trichuris trichiura) :

- Nématode transmis par des œufs infestants par voie ORALE (péril fécal) ; œufs caractéristiques en forme de CITRON (bi-operculés)
- Peut générer une ANÉMIE (infestations massives) ; diagnostic = recherche des œufs dans les selles (EPS)
- Traitement = flubendazole (Fluvermal)
- ▲ FAUX : adulte hermaphrodite ; mis en évidence dans le sang périphérique ; transmis par voie transcutanée (c'est oral)

- **▲ FAUX** : migration dans les voies lymphatiques ; donne la « gourme des mineurs » (= ankylostome)

📖 Vu : 2020N Q39, 2025 Q13

Atteinte hépatique parasitaire (rappel transversal) :

- Parmi les parasites cités, c'est *Entamoeba histolytica* (abcès amibien) qui donne une atteinte hépatique
- **▲ FAUX** : *Enterobius* (oxyure), *Giardia*, *Trichuris*, *Candida albicans* comme cause d'atteinte hépatique

📖 Vu : 2024Exc Q42

[RANG 5] INFECTION PAR LE VIH

– • ~2.38 Q/examen

📖 Classification CDC (stades A/B/C) – pathologies classantes = stade C (SIDA)

Indications du dépistage VIH (~6×) :

- Devant : ZONA (surtout sujet jeune), TUBERCULOSE (ganglionnaire/extra-pulmonaire), maladie de KAPOSI, LEUCOPLASIE chevelue de la langue, candidose œsophagienne, hépatite B/C, IST, diarrhée CHRONIQUE, fièvre persistante, méningite tuberculeuse/cryptococcique
- **▲ FAUX (PAS une indication spécifique)** : herpès labial banal (piège A très récurrent), TIAC, diarrhée AIGUË, COVID-19, infection urinaire à *Candida*, méningite à méningocoque, cancer du pancréas

📖 Vu : 2019N Q13, 2019R Q9, 2020R Q46, 2021R Q17, 2026 Q12 (~6×)

Diagnostic biologique – dépistage vs confirmation :

- Dépistage : test rapide (TDR) ou ELISA (4^e génération Ag p24 + Ac)
- Confirmation : WESTERN BLOT et/ou charge virale (PCR ARN VIH)
- Enfant < 18 mois : confirmation par DEUX PCR VIH positives (les Ac maternels transmis rendent la sérologie ininterprétable)
- **▲ FAUX** : ELISA comme test de CONFIRMATION ; Western Blot en 1^{re} intention pour le dépistage ; charge virale comme dépistage de 1^{re} intention

📖 Vu : 2020N Q13, 2022N Q43, 2023N Q16/Q17, 2026 Q13

Histoire naturelle :

- Évolution en 3 STADES : primo-infection → phase asymptomatique (latence clinique) → SIDA
- Corrélation inverse : plus la charge virale augmente, plus les CD4 baissent
- Primo-infection : réplication virale INTENSE (pic de charge virale), symptomatique dans ~50-70 % des cas seulement
- La survenue des infections opportunistes DÉPEND du taux de CD4
- **▲ FAUX** : évolution en 4 phases (la clé FMPM retient 3 stades) ; réplication faible en primo-infection ; primo symptomatique à 100 % ; IO indépendantes des CD4

📖 Vu : 2021R Q19, 2026 Q11

Bilan initial & prise en charge :

- Bilan initial : NFS, taux de CD4, charge virale, sérologies hépatites B et C, sérologie syphilis
- Traitement : TRITHÉRAPIE antirétrovirale démarrée QUEL QUE SOIT le taux de CD4 (« treat all ») ; restaure l'immunité (remontée des CD4)
- Dépister le partenaire ; dépister l'enfant si la mère est infectée ; DÉCLARATION ANONYME de l'infection VIH
- **▲ FAUX : démarrer la trithérapie seulement si $CD4 < 200$ (ou < 50) ; Bithérapie (2 molécules) ; durée de 28 jours ; annoncer la séropositivité à la famille (confidentialité)**
- **▲ FAUX : ponction lombaire dans le bilan initial systématique**

📖 Vu : 2020N Q13/Q14, 2022N Q44, 2024N Q19, 2026 Q14

Prophylaxie des infections opportunistes selon les CD4 :

- COTRIMOXAZOLE : prévient la PNEUMOCYTOSE et la TOXOPLASMOSE cérébrale → si $CD4 < 200/mm^3$
- ISONIAZIDE 5 mg/kg/j × 9 mois : prophylaxie de la TUBERCULOSE
- Tuberculose au cours du VIH : toujours dépistée, peut révéler le VIH ; sa forme DISSÉMINÉE témoigne d'un stade AVANCÉ
- **▲ FAUX : le cotrimoxazole prévient la tuberculose, l'herpès, la candidose œsophagienne ou le CMV (il prévient pneumocystose + toxoplasmose)**
- **▲ FAUX : la tuberculose disséminée se voit à un stade PRÉCOCE (c'est un stade tardif)**

📖 Vu : 2019N Q14, 2019R Q10, 2020R Q45, 2021R Q16, 2020N Q14

Atteinte neurologique chez le VIH+ (HTIC fébrile) :

- Devant une HTIC fébrile chez un VIH+ : évoquer méningo-encéphalite TUBERCULEUSE, CRYPTOCCOSE neuroméningée et TOXOPLASMOSE cérébrale
- 1^{er} examen = SCANNER cérébral (avant la PL, pour éliminer un processus expansif)
- Lésions multiples EN COCARDE avec effet de masse → TOXOPLASMOSE cérébrale ; encre de chine + → cryptococcose
- **▲ FAUX : ponction lombaire d'emblée devant une HTIC ; méningite à méningocoque/pneumocoque dans ce contexte d'immunodépression chronique**

📖 Vu : 2025 Q37/Q38/Q39, 2026 Q48

Manifestations cutanéomuqueuses & stade :

- Lésions nodulaires/infiltrées VIOLACÉES (bouche, visage) → maladie de KAPOSI (HHV-8)
- Toute pathologie opportuniste classante (Kaposi, toxoplasmose cérébrale, cryptococcose, pneumocystose, candidose œsophagienne, TB) → STADE C (= SIDA)
- **▲ FAUX : confondre Kaposi avec candidose, aphtes, purpura ou leucoplasie chevelue**

📖 Vu : 2024N Q18, 2024Exc Q14, 2025 Q40, 2024R Q4

Épidémiologie au Maroc :

- VIH-1 prédominant ; transmission dominante = HÉTÉROSEXUELLE ; concentration en milieu URBAIN ; Marrakech-Safi parmi les régions les plus touchées ; prévalence plus élevée chez les populations clés (professionnels du sexe)

- **▲ FAUX** : VIH-2 le plus répandu en Europe/Amérique ; transmission mère-enfant = principale voie au Maroc ; même prévalence population générale vs travailleurs du sexe

📖 Vu : 2021R Q18, 2026 Q10

[RANG 6] LEISHMANIOSES

– • ~2.08 Q/examen

Parasite, vecteur & formes – bases (très répété) :

- Agent = protozoaire flagellé du genre *Leishmania* ; transmission par piqûre du PHLÉBOTOME femelle (vecteur)
- Forme AMASTIGOTE = intracellulaire, dans les MACROPHAGES du système réticulo-endothélial (SRE), non flagellée – forme observée chez l'Homme
- Forme PROMASTIGOTE = flagellée, mobile, dans le tube digestif du vecteur et en culture (milieu NNN)
- Réservoir variable selon l'espèce (chien, rongeurs, Homme)
- **▲ FAUX** : vecteur = anophèle (= paludisme) ou glossine (= trypanosomiase) – c'est le PHLÉBOTOME (piège récurrent)
- **▲ FAUX** : amastigote dans les hématies (= Plasmodium) – c'est dans le macrophage
- **▲ FAUX** : amastigote flagellé / promastigote chez l'Homme – inverse

📖 Vu : 2019N, 2020N, 2021N, 2024N, 2024R, 2025, 2026 (récurrent)

Leishmaniose VISCÉRALE (kala-azar) – *L. infantum* :

- Agent au Maroc = *Leishmania infantum* ; touche surtout l'ENFANT ; réservoir = CHIEN ; atteinte du SRE
- Triade : fièvre ANARCHIQUE (folle, désordonnée) + SPLÉNOMÉGALIE (volumineuse) + PÂLEUR (anémie)
- Biologie : PANCYTOPÉNIE (anémie + leucopénie + thrombopénie) + HYPERGAMMAGLOBULINÉMIE polyclonale
- Diagnostic = mise en évidence des amastigotes dans la MOELLE OSSEUSE (myélogramme) + sérologie + PCR
- Évolution MORTELLE en l'absence de traitement
- **▲ FAUX** : anémie hémolytique – la cytopénie est CENTRALE (envahissement médullaire), c'est une pancytopenie
- **▲ FAUX** : hyperleucocytose – il y a LEUCOPÉNIE
- **▲ FAUX** : diagnostic sur frottis sanguin de routine / biopsie cutanée pour la forme viscérale

📖 Vu : 2019R, 2020N, 2021R, 2024N, 2024R, 2025 (récurrent)

Leishmanioses CUTANÉES (bouton d'Orient) :

- Forme ZOONOTIQUE = *L. major* : zones présahariennes (Tata, Zagora, Ouarzazate) ; réservoir = rongeur (*Meriones shawi*) ; lésion ulcéro-croûteuse humide
- Forme ANTHROPONOTIQUE = *L. tropica* : foyers urbains (Essaouira, Chichaoua, Imintanout) ; réservoir = Homme ; lésion sèche
- Diagnostic = recherche d'amastigotes par RACLAGE/grattage de la BORDURE de la lésion + culture sur milieu NNN (→ promastigotes) + PCR

- Traitement de référence = antimoniate de méglumine (GLUCANTIM), voie locale ou générale
- ⚠ FAUX : sérologie pour le diagnostic de la forme CUTANÉE – peu/non contributive (réservée à la viscérale)
- ⚠ FAUX : prélèvement au centre de la lésion – c'est sur la BORDURE active
- ⚠ FAUX : L. major = forme urbaine anthroponotique – c'est l'inverse (L. major = zoonotique rurale)
- ⚠ FAUX : culture sur Sabouraud (= champignons) – c'est le milieu NNN

📖 Vu : 2019N, 2020R, 2021N, 2022N, 2024N, 2026 (récurrent)

Prophylaxie :

- Lutte anti-vectorielle : moustiquaires imprégnées, insecticides, port de vêtements couvrants au crépuscule
- Dépistage et traitement des malades (réservoir humain pour L. tropica) ; lutte contre les réservoirs (chiens errants, rongeurs)
- ⚠ FAUX : « s'éloigner des chats » (= toxoplasmose) ; vaccination disponible ; chimioprophylaxie médicamenteuse

📖 Vu : sessions diverses

[RANG 7] LEVURES ET LEVUROSES

– • ~1.92 Q/examen

Candida albicans (~6×) :

- Levure COMMENSALE des muqueuses digestives et vaginales (PAS de la peau, PAS du tractus respiratoire) ; NON capsulée ; assimile et fermente le glucose ; test de blastèse positif
- Opportuniste : l'immunodépression favorise les formes invasives ; superficielles = muguet buccal (enduit blanchâtre, terrain VIH), perlèche, intertrigo des plis, onyxis avec PÉRI-onyxis (mains++), candidose œsophagienne, candidose vulvo-vaginale, fièvre persistante malgré ATB chez patient à risque
- Candidoses systémiques NOSOCOMIALES – FDR : séjour en réanimation, cathéter veineux central, chirurgie abdominale lourde ; FDR superficielles : macération, âges extrêmes, traumatismes, œstroprogestatifs, diabète
- ⚠ FAUX : levure CAPSULÉE (= Cryptococcus) ; commensale de la peau/respiratoire ; paroi contenant le GALACTOMANNANE (= Aspergillus)
- ⚠ FAUX (FDR candidose systémique) : traitement antiépileptique, HTA

📖 Vu : 2019N Q48/Q50, 2022N Q24, 2023N Q50, 2025 Q22, 2026 Q46/Q47

Cryptococcus neoformans – neuro-méningé (~7×) :

- LEVURE CAPSULÉE (capsule polysaccharidique), opportuniste, tropisme pour le SNC ; terrain immunodéprimé VIH/SIDA (CD4 < 100) ; transmission par INHALATION (fientes de pigeons)
- Diagnostic neuro-méningé : (1) ANTIGÈNE capsulaire polysaccharidique dans le LCR, (2) levures encapsulées à l'ENCRE DE CHINE, (3) culture sur Sabouraud
- Évolution sans traitement → coma et décès

- **▲ FAUX** : recherche d'ANTICORPS dans le LCR (c'est l'antigène) ; forme FILAMENTEUSE (c'est une levure) ; oocystes ; goutte épaisse ; piqure de moustique ; champignon dimorphique

📖 Vu : 2019N Q47, 2019R Q48, 2020N Q45, 2020R Q20, 2021N Q33, 2021R Q50, 2022N Q21, 2025 Q23 (≈7×)

Malassezia furfur & pityriasis versicolor (~3×) :

- Levure LIPOPHILE, commensale de la peau, produisant du mycélium dans l'épiderme
- Manifestation la + fréquente = PITYRIASIS VERSICOLOR : dyschromie squameuse, SIGNE DU COPEAU, favorisé par chaleur/humidité/sudation/peau grasse ; macules ne bronzant pas
- Diagnostic : examen direct des squames (grattage ou SCOTCH-TEST) ; non contagieux, récidivant
- **▲ FAUX** : contagieux ; capsule polysaccharidique ; transmis par inhalation de spores ; culture de routine sur Sabouraud (lipophile → milieu enrichi) ; « ne concerne que l'immunodéprimé »

📖 Vu : 2019R Q46, 2022N Q19, 2025 Q21, 2026 Q50

Pneumocystis jirovecii (~7×) :

- Champignon atypique opportuniste, cosmopolite, NON cultivable sur Sabouraud ; transmission par INHALATION
- Pneumocystose = pneumopathie interstitielle bilatérale chez l'immunodéprimé (VIH CD4 < 200, greffés)
- Diagnostic : identification des KYSTES/trophozoïtes dans les crachats ou le LBA (colorations spécifiques)
- **▲ FAUX** : champignon filamenteux ; culture sur Sabouraud ; diagnostic par sérologie/anticorps ; mortel chez l'immunocompétent ; mycose des zones tropicales ; transmise par les fientes de pigeons (= Cryptococcus) ; diarrhée verdâtre ; réservoir animal ; dermatophytose

📖 Vu : 2019N Q46, 2020N Q44, 2020R Q19, 2021N Q32, 2021R Q49, 2023N Q49 (≈7×)

Mycoses invasives – agents & aspergillose :

- Agents de mycoses invasives : Candida albicans, Candida glabrata, Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans
- Aspergillose invasive : contamination par INHALATION de spores aspergillaires
- **▲ FAUX** : Malassezia furfur comme agent de mycose invasive (elle est superficielle) ; aspergillose par contact interhumain, ingestion, dépôt sur plaies ou crudités

📖 Vu : 2019N Q29, 2024N Q47

[RANG 8] AMIBES ET AMIBIASES

– • ~1.85 Q/examen

Agent, transmission & formes (très répété) :

- Agent pathogène = Entamoeba histolytica (protozoaire) ; seule amibe réellement pathogène

- Transmission par ingestion de KYSTES mûrs (péril fécal : eau/aliments souillés, mains sales) – maladie des mains sales
- Forme MINUTA = non pathogène, commensale du côlon, hématophage NON ; forme de résistance/dissémination = kyste
- Forme HISTOLYTICA (hématophage) = mobile, grande, phagocyte les hématies, sécrète des enzymes protéolytiques → effraction de la muqueuse colique
- ⚠ FAUX : transmission par les formes végétatives/trophozoïtes – c'est le KYSTE qui est infectant (la forme végétative est fragile, détruite dans l'estomac)
- ⚠ FAUX : sporozoaire / intracellulaire obligatoire / cycle chez un moustique
- ⚠ FAUX : amibiase due à E. dispar (morphologiquement identique mais NON pathogène)

📖 Vu : 2019N, 2020N, 2021N, 2024N, 2025, 2026 (récurrent)

Amibiase intestinale aiguë (dysenterie amibienne) :

- Tableau = syndrome dysentérique : selles afécales GLAIRO-SANGLANTES, épreintes, ténésme, douleurs du cadre colique
- Caractéristique : APYREXIE (pas ou peu de fièvre) et état général conservé au début
- Diagnostic = examen parasitologique des selles (EPS) FRAÎCHES → trophozoïtes hématophages mobiles (formes histolytica)
- Traitement = MÉTRONIDAZOLE (amébicide tissulaire) + amébicide de contact
- ⚠ FAUX : fièvre élevée constante avec AEG (oriente plutôt vers une cause bactérienne)
- ⚠ FAUX : diagnostic par recherche d'oocystes / d'œufs / de larves dans les selles
- ⚠ FAUX : EPS sur selles conservées au froid plusieurs heures (mobilité perdue)

📖 Vu : 2019R, 2020R, 2021R, 2024R, 2025 (récurrent)

Amibiase tissulaire – abcès amibien du foie :

- Complication la + fréquente de l'amibiase tissulaire = abcès AMIBIEN du FOIE (sérologie+)
- Clinique : hépatomégalie douloureuse fébrile ; l'EPS est souvent NÉGATIF à ce stade
- Diagnostic = SÉROLOGIE amibienne (anticorps) + imagerie (échographie) ; ponction = pus « chocolat »
- Traitement = métronidazole
- ⚠ FAUX : diagnostic de l'abcès hépatique par EPS positif (il est souvent négatif → la sérologie prend le relais)
- ⚠ FAUX : abcès dû à E. dispar / localisation pulmonaire la plus fréquente

📖 Vu : 2019N, 2021N, 2024N (récurrent)

Prophylaxie :

- Lavage des mains, lavage des fruits et légumes, protection de l'eau de boisson, hygiène fécale ; lutte contre le péril fécal
- ⚠ FAUX : vaccination ; chimioprophylaxie ; éviter les piqûres d'insectes (pas de vecteur)

📖 Vu : sessions diverses

[RANG 9] LEPTOSPIROSES

– • ~1.85 Q/examen

Agent, terrain & transmission (très répété) :

- Agent = *Leptospira interrogans* (bactérie spirochète) ; transmission par PÉNÉTRATION TRANSCUTANÉE (peau lésée/muqueuses) au contact d'eau souillée par les urines de rongeurs
- PROFESSIONS à risque (argument épidémiologique majeur) : égoutier, éboueur, plombier, ouvrier agricole, employé de hammam
- Incubation 2 à 21 jours ; forme la plus FRÉQUENTE = pseudo-grippale ; forme grave = leptospirose ICTÉRO-HÉMORRAGIQUE (syndrome de Weil)
- ⚠ FAUX : infection virale (c'est une bactérie) ; transmise par piqûre d'insecte (c'est transcutanée)
- ⚠ FAUX : incubation de 2 mois

📖 Vu : 2022N Q29, 2024N Q3, 2026 Q1 (récurrent)

Forme ictéro-hémorragique – tableau clinico-biologique (le + posé) :

- ICTÈRE FLAMBOYANT (orangé) + INSUFFISANCE RÉNALE aiguë (oligo-anurie, créatinine élevée – non obstructive fébrile) + SYNDROME HÉMORRAGIQUE (épistaxis, hémoptysies, secondaire à la THROMBOPÉNIE)
- Hyperhémie/suffusion conjonctivale, myalgies intenses (mollets) ; atteinte neuro-méningée possible = méningite à LIQUIDE CLAIR (lymphocytaire)
- Hémogramme : HYPERLEUCOCYTOSE à PNN + THROMBOPÉNIE + anémie normocytaire régénérative
- ⚠ FAUX : LCR PURULENT ou HYPOGLYCORACHIE en cas de méningite – le LCR est CLAIR (piège récurrent)
- ⚠ FAUX : injection conjonctivale = signe PATHOGNOMONIQUE (elle est non spécifique) ; ictère obligatoire dans toutes les formes ; diurèse toujours conservée ; atteinte respiratoire constante
- ⚠ FAUX hémogramme : hyperéosinophilie ; lymphopénie profonde isolée

📖 Vu : 2019N Q2, 2019R Q20, 2021R Q1, 2022N Q29, 2024R Q23, 2025 Q35, 2026 Q2/Q3 (récurrent)

Facteurs de mauvais pronostic :

- Insuffisance rénale (créatinine élevée), troubles de conscience (Glasgow bas), détresse respiratoire, troubles de la REPOLARISATION à l'ECG (atteinte myocardique)
- ⚠ FAUX : l'âge de 40 ans ; l'ictère isolé ; l'injection conjonctivale ; la toux productive comme facteurs de gravité

📖 Vu : 2019N Q4, 2019R Q22, 2022N Q30 (récurrent)

Diagnostic & traitement :

- Diagnostic de confirmation = SÉROLOGIE de MARTIN ET PETIT (test de micro-agglutination MAT)
- Traitement = β -lactamines : PÉNICILLINE G, amoxicilline ou ceftriaxone IV (formes graves) ; doxycycline (formes légères)
- ⚠ FAUX diagnostic : sérologie de Widal-Félix (= typhoïde/rickettsiose) ; sérologie de Wright (= brucellose) ; myéloculture ; goutte épaisse

- **▲ FAUX traitement : VANCOMYCINE (jamais indiquée) ; gentamicine ; ciprofloxacine ; rifampicine ; azithromycine en 1^{re} intention**

📖 Vu : 2019N Q3, 2019R Q21, 2020N Q22, 2020R Q27/Q28, 2021R Q2, 2025 Q36 (récurrent)

[RANG 10] RICKETTSIOSES – FIÈVRE Q

– • ~1.85 Q/examen

Fièvre boutonneuse méditerranéenne (FBM) – agent & vecteur (très répété) :

- Agent = Rickettsia CONORII (bactérie INTRACELLULAIRE STRICTE) ; réservoir ET vecteur = la TIQUE DU CHIEN (Rhipicephalus sanguineus)
- Piqûre de tique INDOLORE ; maladie ESTIVALE (sévit surtout en été) ; incubation 7-12 jours
- Les tiques transmettent aussi la maladie de LYME (borréliose) – mais PAS le paludisme, la leptospirose, ni la brucellose
- **▲ FAUX : agent = Rickettsia typhi / prowazekii / rickettsii – c'est R. CONORII (piège récurrent)**
- **▲ FAUX : agent transmis par les poux ; réservoir humain ; le chien n'a aucun rôle ; piqûre douloureuse ; maladie hivernale**

📖 Vu : 2019N Q5, 2019R Q18, 2021R Q12, 2024R Q7/Q9, 2026 Q16 (récurrent)

FBM – clinique : tache noire & exanthème (le + posé) :

- TACHE NOIRE (escarre d'inoculation) = lésion PATHOGNOMONIQUE et porte d'entrée ; mais PEUT être absente, multiple, siéger au cuir chevelu, ou d'aspect non spécifique
- Triade : fièvre élevée + céphalées intenses + EXANTHÈME maculo-papuleux puis purpurique, évoluant en POUSSÉES, ATTEIGNANT les PAUMES et les PLANTES
- Phase d'état : accentuation des signes généraux ; atteinte conjonctivale possible (rare) ; le PURPURA est un signe de gravité
- **▲ FAUX : la tache noire est présente dans TOUS les cas (elle peut manquer) ; elle constitue un signe de gravité (non)**
- **▲ FAUX : l'exanthème ÉPARGNE les paumes et les plantes (au contraire, il les atteint – différence avec la typhoïde) ; érythème migrant chronique (= Lyme)**

📖 Vu : 2020N Q7, 2022N Q36, 2023N Q18, 2024N Q21/Q22, 2024R Q8, 2026 Q17/Q18 (récurrent)

FBM – biologie & traitement :

- Biologie : LDH élevés, thrombopénie, VS/CRP élevées, cytolysé hépatique ; la non-amélioration sous AMOXICILLINE oriente vers la FBM (bactérie intracellulaire → résistante aux β-lactamines)
- Traitement = DOXYCYCLINE (cycline, 1^{re} intention) ; chez la femme enceinte/l'enfant = JOSAMYCINE (macrolide)
- **▲ FAUX biologie : thrombocytose ; VS normale**
- **▲ FAUX traitement : pénicilline G/A, amoxicilline, ceftriaxone, cotrimoxazole, rifampicine**

📖 Vu : 2019N Q6, 2019R Q19, 2020N Q9, 2021R Q15, 2023N Q19 (récurrent)

Fièvre Q (Coxiella burnetii) :

- Agent = COXIELLA BURNETII (et NON une Rickettsia) ; transmission surtout AÉRIENNE (inhalation d'aérosols), aussi par produits laitiers ; réservoir = bétail
- Forme aiguë (pseudo-grippale, pneumopathie, hépatite) ; forme CHRONIQUE = ENDOCARDITE ; diagnostic SÉROLOGIQUE
- ▲ FAUX : agent = virus ; tache noire pathognomonique (= FBM) ; transmission UNIQUEMENT par produits laitiers ou UNIQUEMENT aérienne
- ▲ FAUX : évolution vers la forme chronique dans la MAJORITÉ des cas (la majorité guérit) ; sérologie sans intérêt ; incubation de 5 mois

📖 Vu : 2019R Q25, 2020R Q42, 2021R Q12 (récurrent)

[RANG 11] LE TÉTANOS

– • ~1.77 Q/examen

Agent, portes d'entrée & clinique (très répété) :

- Agent = Clostridium tetani (bacille anaérobie sporulé tellurique) ; toxine = TÉTANOSPASMINE ; maladie NON immunisante, NON contagieuse
- PORTES D'ENTRÉE : plaie souillée/négligée (tellurique), morsure d'animal, injection IM, OMBILICALE (tétanos néonatal), UTÉRINE (post-abortum/post-partum), chirurgie
- TRISMUS = PREMIER signe (contracture involontaire, douloureuse, invincible, SYMÉTRIQUE des masséters → limitation douloureuse de l'ouverture de la bouche), apparaît 3 à 21 jours après la plaie
- Puis contractures DESCENDANTES se généralisant + paroxysmes/spasmes ; complications infectieuses et thrombo-emboliques possibles
- ▲ FAUX : progression ASCENDANTE des contractions (elle est descendante) ; trismus = dernier signe (c'est le premier) ; contracture asymétrique
- ▲ FAUX : porte d'entrée DIGESTIVE par toxi-infection alimentaire (= botulisme/TIAC, pas le tétanos)

📖 Vu : 2019R Q24, 2021N Q22, 2021R Q25, 2022N Q46/Q47, 2024N Q14, 2024R Q12, 2025 Q28 (récurrent)

Diagnostic – STRICTEMENT CLINIQUE (le + posé, ~6×) :

- Le diagnostic du tétanos est STRICTEMENT CLINIQUE ; aucun test biologique ne le confirme
- ▲ FAUX : recherche de la TOXINE au niveau de la plaie ; sérologie du tétanos ; PCR ou hémocultures dans le sang ; scanner cérébral – aucun ne confirme le diagnostic (piège systématique)

📖 Vu : 2019N Q23, 2020N Q24, 2024N Q15, 2024R Q13 (~6×)

Score de DAKAR – facteurs de gravité (très répété) :

- Incubation (plaie → trismus) COURTE < 7 jours = grave ; invasion (trismus → généralisation) COURTE < 48 h = grave
- Porte d'entrée OMBILICALE / UTÉRINE / chirurgicale / brûlure / IM = grave (une plaie de membre n'est pas cotée comme grave)
- Présence de PAROXYSMES/spasmes ; FIÈVRE > 38,4 °C ; tachycardie (pouls > 120/min)

- **▲ FAUX** : une incubation LONGUE (15 jours) = signe de gravité – c'est une incubation COURTE qui est grave (piège majeur)
- **▲ Note** : selon la durée donnée dans l'énoncé, la clé coche l'incubation OU l'invasion selon laquelle passe sous le seuil (incubation < 7 j / invasion < 48 h)

📖 Vu : 2020R Q49, 2021N Q23, 2022N Q48, 2023N Q20, 2024N Q16, 2024R Q14 (récurrent)

Prévention :

- VACCINATION antitétanique (anatoxine) = seule protection durable ; vaccination des femmes en âge de procréer (prévention du tétanos néonatal)
- Parage/désinfection des plaies (eau + savon) ; SÉRUM/immunoglobulines antitétaniques selon le statut vaccinal et le type de plaie ; stérilisation du matériel chirurgical
- **▲ FAUX** : administration d'immunoglobulines QUEL QUE SOIT l'état vaccinal (la conduite dépend du statut vaccinal)
- **▲ FAUX** : la prise d'ANTIBIOTIQUES prévient le tétanos (les antibiotiques ne préviennent pas la maladie)

📖 Vu : 2021N Q24, 2024R Q15 (récurrent)

[RANG 12] LA RAGE HUMAINE

– • ~1.69 Q/examen

Agent, transmission & pronostic (très répété) :

- Agent = VIRUS rabique (Lyssavirus à ARN) → ENCÉPHALOMYÉLITE VIRALE ; maladie à DÉCLARATION OBLIGATOIRE ; une fois DÉCLARÉE, elle est TOUJOURS MORTELLE
- Transmission par un animal enragé (chien ++, animaux domestiques/sauvages) : MORSURE, GRIFFURE, LÉCHAGE d'une MUQUEUSE ou d'une peau LÉSÉE, GREFFE d'organe
- Le virus NE traverse PAS la peau SAINE (léchage de peau saine = pas de transmission) ; incubation variable selon le SIÈGE de la morsure (plus proche du SNC = incubation plus COURTE)
- **▲ FAUX** : encéphalomyélite BACTÉRIENNE (elle est virale) ; le virus traverse la peau saine
- **▲ FAUX** : « plus le siège de la morsure est loin du cerveau, plus l'incubation est courte » – c'est l'INVERSE (loin du SNC → incubation longue)

📖 Vu : 2019N Q18, 2019R Q4, 2025 Q26, 2026 Q23/Q24 (récurrent)

Formes cliniques (le + posé) :

- RAGE FURIEUSE (encéphalitique) : excitation psychomotrice, hallucinations, hypersalivation, HYDROPHOBIE + AÉROPHOBIE = signes PATHOGNOMONIQUES
- RAGE PARALYTIQUE : paralysie (membres inférieurs), état de CONSCIENCE CONSERVÉ, sans hallucinations
- Diagnostic essentiellement CLINIQUE chez l'Homme symptomatique
- **▲ FAUX** signes « pathognomoniques » : signe de l'abaisse-langue captif, fièvre, troubles de conscience (les vrais sont hydrophobie + aérophobie)
- **▲ FAUX** : dans la rage paralytique, conscience très altérée / excitation psychomotrice / hallucinations (c'est la forme furieuse)

📖 Vu : 2020N Q1, 2020R Q47, 2023N Q3, 2024N Q17 (récurrent)

Traitement de la maladie déclarée :

- UNIQUEMENT SYMPTOMATIQUE : hospitalisation en réanimation, réhydratation IV, tranquillisants/sédation, isolement
- **▲ FAUX** : administration d'ANTIVIRAUX (aucun traitement curatif) ; (re)commencer la vaccination une fois la maladie déclarée (inutile) ; laisser un membre de la famille avec le patient

📖 Vu : 2020N Q2, 2021R Q23, 2023N Q4 (récurrent)

Prophylaxie post-exposition (PPE) – la vraie prévention (très répété) :

- Lavage immédiat de la plaie à l'eau et au savon (même cicatrisée) + désinfection ; un sujet asymptomatique mordu (même des mois avant) relève de la VACCINATION antirabique
- VACCINATION antirabique post-exposition (protocoles ESSEN ou ZAGREB) ; vaccination PRÉ-exposition possible chez les sujets à risque
- SÉROTHÉRAPIE (immunoglobulines) selon la GRAVITÉ (catégorie III/grade 4 : morsures profondes/multiples, léchage de muqueuse), administrée AU NIVEAU de la morsure EN MÊME TEMPS que la 1^{re} injection de vaccin ; + prévention du TÉTANOS + antibioprophylaxie
- **▲ FAUX** : prévention par administration d'ANTIBIOTIQUES (les antibiotiques préviennent la surinfection, PAS la rage)
- **▲ FAUX** sérothérapie : indiquée quel que soit le type de lésion ; administrée par voie IV ; administrée après le 7^e jour ; n'existe que sous forme d'immunoglobulines humaines

📖 Vu : 2019N Q19, 2019R Q5, 2021N Q9, 2022N Q45, 2023N Q1/Q2, 2024R Q16, 2025 Q27 (récurrent)

[RANG 13] ACCIDENTS D'EXPOSITION AU SANG (AES)

– • ~1.62 Q/examen

Définition – ce qui EST / N'EST PAS un AES (le + posé) :

- AES = contact accidentel avec du sang/liquide biologique contaminé, par effraction cutanée (piqûre, coupure) ou projection sur muqueuse / peau LÉSÉE
- SONT des AES : piquûre par aiguille creuse souillée, coupure par bistouri pendant l'acte, projection de sang sur une plaie/dans les yeux, morsure profonde par un malade, projection de liquide amniotique dans les yeux
- **▲ FAUX (NE sont PAS des AES)** : projection de sang sur une PEAU SAINE intacte ; piquûre par aiguille STÉRILE ou coupure par bistouri AVANT son utilisation sur le patient (pas de contact avec sang contaminé)

📖 Vu : 2019N Q24, 2019R Q1, 2021R Q8 (récurrent)

Conduite immédiate & geste à éviter (très répété) :

- ARRÊTER le geste / le confier à un collègue → LAVER immédiatement à l'eau et au savon → ANTISEPSIE par trempage/contact PROLONGÉ (≥ 5 min) avec Dakin, polyvidone iodée ou ALCOOL à 70°
- En cas de projection OCULAIRE : rinçage abondant au sérum physiologique/eau (PAS d'alcool dans les yeux)

- DÉCLARER systématiquement l'AES comme accident du travail (médecin du travail/référent) ; évaluer le patient SOURCE : sérologie VIH, Ag HBs, Ac anti-VHC
- **▲ FAUX** : *PRESSER la plaie / la faire SAIGNER (geste à ÉVITER – piège systématique) ; appliquer un garrot ; eau de Javel*
- **▲ FAUX** : *antisepsie seulement quelques secondes / uniquement par l'alcool ; déclaration non systématique ; faire un don de sang pour vérifier sa sérologie*

📖 Vu : 2020N Q18, 2020R Q50, 2021N Q17, 2021R Q9, 2023N Q11, 2024N Q7, 2024R Q10, 2026 Q7 (récurrent)

Facteurs de risque & prophylaxie post-exposition VIH :

- Risque ÉLEVÉ : blessure PROFONDE, aiguille CREUSE de gros calibre, geste intravasculaire (après ponction veineuse), charge virale source élevée, sang visible
- Prophylaxie VIH = TRIthérapie ARV à débiter au plus TÔT (idéalement < 4 h), AU PLUS TARD 72 h après l'exposition, pour une durée de 28 JOURS (4 semaines)
- **▲ FAUX risque** : *aiguille pleine/superficielle ; charge virale source indétectable ; aiguille creuse AVANT le geste sur le patient ; délai > 8 h (faible risque)*
- **▲ FAUX prophylaxie** : *durée de 3 mois ou 14 jours (c'est 28 jours) ; BIthérapie (c'est une trithérapie) ; débiter dans les 7 jours ; indiquée uniquement si la source est au stade SIDA*

📖 Vu : 2020N Q17, 2021N Q17, 2021R Q9, 2024R Q10, 2026 Q8/Q9 (récurrent)

Hépatite B/C & prévention des AES :

- Hépatite B : victime VACCINÉE avec Ac anti-HBs > 10 UI/mL (ex. 100 UI/mL) = PROTÉGÉE → arrêter le suivi VHB ; si NON vaccinée + source HBV+ → vaccination ± immunoglobulines anti-HBs
- Hépatite C : pas de prophylaxie ni de vaccin → surveillance sérologique ; bilan d'une victime vaccinée = Ac anti-HBs, Ac anti-VHC, ALAT, sérologie VIH
- Prévention : porter des gants, NE PAS recapuchonner ni désadapter les aiguilles à la main, conteneurs pour objets piquants/tranchants, trier les déchets
- **▲ FAUX** : *recapuchonner / désadapter les seringues après usage (= erreurs favorisant l'AES, piège récurrent)*
- **▲ FAUX** : *dépister tous les patients pour le VIH avant tout soin (pas une mesure de prévention des AES)*

📖 Vu : 2020N Q18, 2024N Q8/Q9, 2024R Q11, 2025 Q44/Q45 (récurrent)

[RANG 14] TOXOPLASMOSES

– • ~1.54 Q/examen

Parasite, hôtes & formes (très répété) :

- Agent = Toxoplasma gondii ; HÔTE DÉFINITIF = le CHAT (félidés) ; l'Homme est un HÔTE INTERMÉDIAIRE
- Multiplication INTRACELLULAIRE obligatoire ; chez l'Homme par schizogonie (multiplication asexuée)

- Formes : tachyzoïte (forme proliférative active) ; KYSTE = forme de RÉSISTANCE (tissus : muscle, cerveau) ; OOCYSTE = éliminé dans les selles du CHAT
- ▲ FAUX : Homme = hôte définitif – il est hôte INTERMÉDIAIRE (piège A très récurrent)
- ▲ FAUX : tachyzoïte = forme de résistance – c'est le KYSTE (piège E récurrent)
- ▲ FAUX : multiplication EXTRACELLULAIRE – elle est intracellulaire obligatoire
- ▲ FAUX : oocyste éliminé dans les selles de l'Homme/du malade – c'est le CHAT

📖 Vu : 2019N Q36, 2020N Q35, 2021N Q30, 2023N Q31 (récurrent)

Modes de transmission (~6×) :

- Ingestion de viande peu cuite (kystes) ; ingestion d'oocystes (déjections de chat, crudités/légumes mal lavés, jardinage)
- Voie TRANSPLACENTAIRE lors d'une séroconversion PERGRAVIDIQUE (toxoplasmose congénitale)
- Transmission lors de GREFFE d'organe / transplantation (moelle, organe solide)
- ▲ FAUX : transmission par poisson mal cuit/fumé
- ▲ FAUX : transmission par voie sexuelle / « entre homosexuels »
- ▲ FAUX : transmission par excréments de CHIEN – c'est le chat

📖 Vu : 2019N Q36, 2020N Q35, 2022N Q7 (récurrent)

Prophylaxie chez la femme enceinte SÉRONÉGATIVE (le + posé, ~9×) :

- S'ÉLOIGNER DES CHATS ; éviter la consommation de VIANDE PEU CUITE
- Laver soigneusement fruits et légumes ; se laver les mains après le jardinage
- Surveillance : SÉROLOGIES MENSUELLES ; consulter en cas d'adénopathies cervicales
- ▲ FAUX : mise sous SPIRAMYCINE à titre PROPHYLACTIQUE chez la séronégative – la spiramycine est un traitement CURATIF en cas de séroconversion, pas une prophylaxie systématique (piège E très récurrent)
- ▲ FAUX : s'éloigner des chiens / s'interdire le poisson fumé / éviter les légumes frais (au lieu de les laver)
- ▲ FAUX : ne pas consommer de viande du tout ; mettre des vêtements longs au crépuscule (= leishmaniose/paludisme)

📖 Vu : 2019R Q36, 2021R Q30, 2023N Q32, 2024N Q31, 2024R Q31, 2026 Q30 (~9×)

Toxoplasmose materno-fœtale & diagnostic prénatal (~7×) :

- Concerne la femme SÉRONÉGATIVE avant la grossesse ; les formes inapparentes sont les plus fréquentes
- RISQUE inversement proportionnel à la gravité : transmission plus FRÉQUENTE en fin de grossesse, mais plus GRAVE (malformations) si contamination PRÉCOCE (1^{er} trimestre)
- Peut entraîner avortement / malformations ; diagnostic prénatal = recherche de l'ADN toxoplasmique (PCR) dans le LIQUIDE AMNIOTIQUE
- Recommandé en cas d'anomalie fœtale échographique
- ▲ FAUX : diagnostic prénatal par recherche d'ANTICORPS dans le liquide amniotique – c'est l'ADN/PCR (piège récurrent)
- ▲ FAUX : recherche du parasite/des anticorps sur sang fœtal ou sang de cordon en 1^{re} intention

- **▲ FAUX** : concerne les femmes immunisées avant la grossesse

📖 Vu : 2020R Q10, 2022N Q8, 2024N Q32, 2024R Q32, 2025 Q7 (récurrent)

Toxoplasmose cérébrale (immunodéprimé) :

- Survient chez l'immunodéprimé : VIH au stade SIDA, sous immunosuppresseurs, corticothérapie à forte dose et au long cours
- **▲ FAUX** : survient chez le sujet séronégatif (c'est une réactivation de kystes → nécessite une immunité antérieure) ; survient sous antibiotiques à large spectre

📖 Vu : 2026 Q31

[RANG 15] FLAGELLOSES DIGESTIVES ET UROGÉNITALES

– • ~1.38 Q/examen

Giardia intestinalis (= duodenalis / lamblia) – cycle & formes (le + posé) :

- Habitat = DUODÉNUM / intestin grêle proximal chez l'hôte définitif (l'Homme) – PAS le côlon
- Transmission par les KYSTES matures (eau contaminée, péril fécal) ; le kyste = élément d'infestation ET de résistance, éliminé dans les selles
- Trophozoïte = forme végétative mobile par FLAGELLES, responsable des symptômes, ne résiste pas dans le milieu extérieur
- Multiplication par division binaire/scissiparité (asexuée), parasite EXTRACELLULAIRE (adhère à la muqueuse)
- **▲ FAUX** : habitat = côlon – c'est le DUODÉNUM (piège récurrent)
- **▲ FAUX** : parasite cilié – il est FLAGELLÉ (cils ≠ flagelles)
- **▲ FAUX** : multiplication par schizogonie / reproduction sexuée / intracellulaire obligatoire
- **▲ FAUX** : transmission par les formes végétatives – c'est par les KYSTES ; recherche par scotch-test anal (= oxyure)

📖 Vu : 2019N Q33, 2020N Q32, 2021N Q29, 2023N Q30, 2024N Q28, 2024R Q26 (récurrent)

Giardiose – pouvoir pathogène & symptômes :

- Pouvoir pathogène = barrière mécanique au niveau du duodénum + captation des acides biliaires → malabsorption
- Symptômes : STÉATORRHÉE, malabsorption, carence en vitamines liposolubles, anémie, RETARD STATURO-PONDÉRAL chez l'enfant
- Diagnostic de la giardiose aiguë = recherche des TROPHOZOÏTES (et kystes) dans les SELLES (EPS)
- **▲ FAUX** : splénomégalie / rectorragie / occlusion intestinale / crachat rectal glairo-sanglant (= amibiase)
- **▲ FAUX** : diagnostic par recherche d'œufs / oocystes / larves / anticorps dans le sang ; leuco-neutropénie

📖 Vu : 2019R Q31, 2020R Q5, 2021R Q28, 2022N Q3, 2024N Q28, 2025 Q5 (récurrent)

Trichomonas vaginalis :

- Protozoaire flagellé responsable d'une INFECTION SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE (IST)

- NE s'enkyste PAS (pas de forme kystique) → ne résiste pas dans le milieu extérieur ; mobile grâce aux FLAGELLES
- Habitat : vagin chez la femme, vésicule séminale/urètre chez l'homme ; clinique = leucorrhées (femme), balanite/urétrite (homme)
- Diagnostic = recherche des TROPHOZOÏTES dans le prélèvement vaginal ou urétral ; traitement = MÉTRONIDAZOLE pour TOUS les partenaires
- ⚠ FAUX : s'enkyste dans les voies urogénitales pour résister (il ne s'enkyste pas – piège récurrent)
- ⚠ FAUX : recherché dans les URINES ou les SELLES – c'est le prélèvement uro-génital
- ⚠ FAUX : sensible à l'ALBENDAZOLE (= antihelminthique) – traitement = métronidazole ; diagnostic par recherche de kystes

📖 Vu : 2019R Q30, 2020R Q7, 2022N Q4, 2026 Q28 (récurrent)

[RANG 16] CESTODES : TAENIASIS & CYSTICERCOSE

– • ~1.15 Q/examen

Taeniasis à Taenia saginata – le + posé (~10×) :

- Cestode (ver plat segmenté en ANNEAUX APLATIS) ; HÔTE DÉFINITIF = L'HOMME, hôte intermédiaire = le BŒUF
- Contamination par ingestion de VIANDE DE BŒUF crue ou mal cuite (contenant les larves cysticerques)
- Diagnostic = œufs dans les selles + au SCOTCH-TEST ANAL (les anneaux migrent par l'anus) + anneaux mobiles dans les selles (EPS)
- NB : avec l'oxyure, T. saginata est le seul helminthe pour lequel le scotch-test anal est contributif
- ⚠ FAUX : contamination par viande de PORC (= T. solium) / mouton / légumes mal lavés / eau souillée / contact avec les anneaux
- ⚠ FAUX : le taeniasis à T. saginata peut se compliquer de CYSTICERCOSE – c'est T. SOLIUM qui donne la cysticercose, PAS T. saginata (piège majeur)
- ⚠ FAUX : diagnostic par larves dans le sang, expectoration, biopsie intestinale, anticorps, ou kystes dans les selles
- ⚠ FAUX : ver hermaphrodite à œufs éperonnés ; prurit anal nocturne (= oxyure) ; splénomégalie ; auto-infestation

📖 Vu : 2020R Q17, 2021N Q37, 2021R Q39, 2022N Q13, 2023N Q45, 2024N Q43/Q44, 2024R Q46, 2025 Q16/Q17, 2026 Q35 (~10×)

Cysticercose (Cysticercus cellulosae = larve de Taenia SOLIUM) :

- Infection de l'Homme par le STADE LARVAIRE de Taenia SOLIUM (l'Homme devient hôte intermédiaire accidentel en ingérant les œufs)
- Manifestations selon le NOMBRE et la LOCALISATION des cysticerques : ÉPILEPSIE (manifestation la plus commune, neurocysticercose), atteintes oculaire et musculaire
- Diagnostic = SÉROLOGIE (anticorps spécifiques) + imagerie ; traitement = antiparasitaires + CORTICOIDES
- ⚠ FAUX : larves de Taenia SAGINATA (c'est T. solium) ; oocystes ; diagnostic par œufs dans les selles

- **▲ FAUX** : affection bénigne sans gravité ; traitement chirurgical seul ; syndrome de Læffler caractéristique ; signes 2 jours après l'infection

📖 Vu : 2019N Q45, 2021N Q43, 2024N Q45 (récurrent)

[RANG 17] TOXI-INFECTIONS ALIMENTAIRES COLLECTIVES (TIAC)

– • ~1.15 Q/examen

Définition & mécanismes – toxinique vs invasif (le + posé) :

- TIAC = au moins 2 CAS groupés de symptomatologie similaire rapportés à une même origine alimentaire ; DÉCLARATION OBLIGATOIRE (par téléphone puis par écrit)
- Mécanisme TOXINIQUE : incubation COURTE (< 12 h), peu/pas de fièvre, diarrhée LIQUIDIENNE/cholériforme – germe type = STAPHYLOCOCCUS AUREUS (entérotoxine ; diagnostic NON basé sur les hémocultures)
- Mécanisme INVASIF : incubation plus LONGUE, FIÈVRE présente, diarrhée GLAIRO-SANGLANTE, localisations extra-digestives possibles – germes : SALMONELLA non typhique (invasif dans ~60 % des cas), Shigella, Campylobacter, Yersinia
- Orientation étiologique = délai d'incubation + présence de fièvre + aspect des selles (sang/glaires)
- **▲ FAUX** : 1 seul cas suffit / 4 cas nécessaires (il en faut ≥ 2) ; la fièvre/la déshydratation est CONSTANTE ; la diarrhée est TOUJOURS toxinique OU TOUJOURS invasive (variable selon le germe)
- **▲ FAUX** : Staphylocoque aureus = mécanisme invasif (il est TOXINIQUE, diarrhée cholériforme) ; confirmer la TIAC à Staph par hémocultures

📖 Vu : 2019N Q9, 2019R Q14, 2020N Q19, 2020R Q48, 2022N Q27, 2023N Q25, 2024N Q10, 2025 Q29 (récurrent)

Traitement & TIAC histaminique :

- Base = traitement SYMPTOMATIQUE (réhydratation ++) ; ANTIBIOTIQUES NON systématiques, réservés aux formes invasives/sévères/terrains à risque (ex. CIPROFLOXACINE)
- ANTIPÉRISTALTIQUES (lopéramide) CONTRE-INDIQUÉS devant un syndrome dysentérique/invasif
- TIAC HISTAMINIQUE (scombroïde) : après POISSON mal conservé (thon, maquereau) → tableau pseudo-allergique (troubles digestifs + flush + céphalées) ; traitement = ANTIHISTAMINIQUES
- **▲ FAUX** : antibiotiques systématiques quel que soit le mécanisme ; lopéramide devant un syndrome dysentérique
- **▲ FAUX** (histaminique) : survient après viande mal conservée ; nécessite une corticothérapie ; prise en charge par antibiothérapie

📖 Vu : 2021R Q7, 2022N Q27, 2024N Q10, 2025 Q30/Q31 (récurrent)

Botulisme :

- Agent = CLOSTRIDIUM BOTULINUM (et NON C. tetani) ; toxine botulique préformée dans l'aliment (CONSERVES artisanales/faites maison) ; réalise une TIAC familiale

- La toxine NE franchit PAS la barrière hémato-encéphalique (action périphérique) → paralysie FLASQUE DESCENDANTE, APYRÉTIQUE, troubles oculaires (PRESBYTIE, diplopie, mydriase) → risque de paralysie des muscles RESPIRATOIRES
- **▲ FAUX** : agent = *Clostridium tetani* (c'est *C. botulinum*) ; transmission RESPIRATOIRE ; atteinte du SNC révélatrice (l'action est périphérique) ; fièvre à 40 °C / fièvre constante ; contamination SEULEMENT digestive

📖 Vu : 2022N Q28, 2023N Q6, 2024N Q11 (récurrent)

[RANG 18] FIÈVRES TYPHOÏDES

– • ~1.08 Q/examen

Clinique de la phase d'état (le + posé) :

- Agent = *Salmonella Typhi* (transmission oro-fécale, péril fécal) ; début PROGRESSIF ; incubation 1-2 semaines
- DISSOCIATION POULS-TEMPÉRATURE (pouls bas/normal malgré fièvre à 40 °C = signe de Faget) + TUPHOS (somnolence, prostration) + CÉPHALÉES + CONSTIPATION (± alternance) + douleurs abdominales + langue saburrale
- TACHES ROSÉES LENTICULAIRES (abdomen), ÉPISTAXIS, splénomégalie (fréquente mais PAS constante), angine de Duguet ; portage chronique du germe possible APRÈS guérison ; localisations extra-digestives possibles
- **▲ FAUX** : le pouls AUGMENTE parallèlement à la température (au contraire, il y a DISSOCIATION – piège systématique)
- **▲ FAUX** : splénomégalie CONSTANTE (elle est fréquente, non constante) ; diarrhée plutôt que constipation (la constipation prédomine) ; absence de taches rosées
- **▲ FAUX** : due à *Salmonella enteritidis* (= TIAC) ; angine érythémato-pultacée ; incubation de 2 h ; mécanisme cholériforme

📖 Vu : 2019N Q7, 2019R Q16, 2020N Q4, 2020R Q44, 2021R Q5, 2024N Q25, 2024R Q17 (récurrent)

Biologie & complications :

- Hémogramme : LEUCOPÉNIE + NEUTROPÉNIE, THROMBOPÉNIE, VS modérément accélérée, cytolysé hépatique modérée
- Complications : PERFORATION INTESTINALE (croissant gazeux sous-diaphragmatique = pneumopéritoine, urgence chirurgicale), hémorragie digestive, ENCÉPHALITE, myocardite
- **▲ FAUX biologie** : HYPERLEUCOCYTOSE, hyperneutrophilie, hyperéosinophilie, VS à 200 mm (la typhoïde donne une LEUCOPÉNIE)

📖 Vu : 2020N Q5/Q6, 2021R Q4/Q6, 2024N Q25 (récurrent)

Diagnostic & traitement :

- Diagnostic = HÉMOCULTURES (1^{re} semaine) + coproculture ; la sérologie de Widal-Félix n'est PAS la clé du diagnostic (interprétation difficile)
- Traitement = FLUOROQUINOLONES (ciprofloxacine), CEFTRIAXONE (C3G), amoxicilline, cotrimoxazole
- **▲ FAUX traitement** : pénicilline M ; DOXYCYCLINE (les cyclines sont inefficaces)

- **▲ FAUX** : Widal-Félix = clé du diagnostic ; mortalité élevée malgré un traitement efficace

📖 Vu : 2019N Q8, 2019R Q17, 2020N Q6, 2021R Q4 (récurrent)

[RANG 19] PROTOZOOSSES INTESTINALES OPPORTUNISTES

– • ~1.00 Q/examen

Agents & caractéristiques (Cryptosporidium, Cystoisospora belli) :

- Agents = coccidies/SPOROZOAIRES intestinaux opportunistes : Cryptosporidium parvum & hominis, Cystoisospora (Isospora) belli
- Développement INTRACELLULAIRE obligatoire (dans les entérocytes)
- Éliminés sous forme d'OOCYSTES dans les selles ; transmission par voie ORO-FÉCALE (péril fécal, eau souillée)
- **▲ FAUX** : éliminés sous forme de KYSTES (dans la lymphe ou les selles) – ce sont des OOCYSTES (piège récurrent)
- **▲ FAUX** : multiplication extracellulaire ; envahissement du système réticulo-endothélial ; transmission transcutanée active
- **▲ FAUX** : transmission par viande peu cuite – c'est oro-fécale

📖 Vu : 2019N Q39, 2023N Q36, 2025 Q6 (récurrent)

Clinique chez l'immunodéprimé (le + posé) :

- Pronostic GRAVE chez l'immunodéprimé (VIH, CD4 bas) ; responsable de diarrhée chez l'enfant et le sujet âgé
- Symptômes en cas d'immunodépression profonde : DIARRHÉE PROFUSE, troubles HYDRO-ÉLECTROLYTIQUES, DÉSHYDRATATION, perte de poids
- **▲ FAUX** : constipation chronique ; aplasie médullaire ; cardiomégalie ; gingivorragies ; thrombopénie ; péritonite
- **▲ FAUX** : atteinte cérébrale dans la forme compliquée – l'atteinte reste intestinale

📖 Vu : 2022N Q6, 2024N Q29, 2024R Q29, 2026 Q27 (récurrent)

Prophylaxie & autres opportunistes :

- Prophylaxie : lavage soigneux des fruits et légumes, eau potable embouteillée (lutte contre le péril fécal)
- Autres agents opportunistes (mycoses) favorisés par l'immunodépression : Cryptococcus neoformans, Candida albicans
- **▲ FAUX** (parasites NON opportunistes, distracteurs fréquents) : Taenia, Ascaris, Enterobius (oxyure), Trichuris (trichocéphale), Ankylostome, dermatophytes (Trichophyton)
- **▲ FAUX** : déparasitage des animaux / interdire l'élevage de pigeons (= cryptococcose)

📖 Vu : 2019R Q37, 2020N Q38, 2021R Q34, 2022N Q5, 2024N Q39

[RANG 20] ÉCHINOCOCCOSES HUMAINES (HYDATIDOSES)

– • ~0.92 Q/examen

Cycle, agent & hôtes (le + posé) :

- Agent = Echinococcus granulosus (cestode) ; maladie due aux LARVES (kyste hydatique) enkystées dans les viscères (FOIE ++, poumon)
- Cycle : hôte DÉFINITIF = le CHIEN/canidés (porte le ver adulte) ; hôte INTERMÉDIAIRE = le MOUTON/herbivores (porte le kyste)
- L'HOMME = hôte INTERMÉDIAIRE ACCIDENTEL → IMPASSE PARASITAIRE ; contamination par ingestion d'œufs (contact chien, mains/aliments souillés)
- L'atteinte OSSEUSE est assimilée à une TUMEUR MALIGNE (évolution agressive)
- ⚠ FAUX : CHIEN = hôte intermédiaire / MOUTON = hôte définitif – c'est l'INVERSE (piège récurrent)
- ⚠ FAUX : le cycle s'effectue dans le tube digestif humain (impasse → pas de cycle chez l'Homme) ; s'enkyste à l'état ADULTE (c'est la LARVE)
- ⚠ FAUX : Glossina/insecte comme vecteur (pas de vecteur) ; larve enkystée = élément infestant (c'est l'ŒUF) ; larves strongyloïdes

📖 Vu : 2019N Q43, 2019R Q42, 2021N Q39, 2021R Q40, 2023N Q41 (récurrent)

Diagnostic & prophylaxie (très répété) :

- Diagnostic = SÉROLOGIE (ELISA) + IMAGERIE (échographie, scanner) + examen de la pièce opératoire
- Prophylaxie : incinérer les viscères parasités des moutons, interdire l'accès des chiens aux abattoirs, VERMIFUGER les chiens, éviter le contact avec le chien
- ⚠ FAUX : diagnostic par PONCTION du kyste (risque de choc anaphylactique + dissémination – contre-indiquée) ; recherche d'œufs/d'adultes dans les selles ou les crachats (impasse → pas de ponte) ; recherche de scolex dans le liquide de ponction
- ⚠ FAUX prophylaxie : éviter la viande de mouton/porc peu cuite – l'hydatidose se contracte par les ŒUFS du chien, PAS par la viande (piège très récurrent) ; vaccination des enfants

📖 Vu : 2020N Q41, 2021R Q41, 2022N Q12, 2024N Q46, 2024R Q47, 2025 Q19 (récurrent)

[RANG 21] GÉNÉRALITÉS PARASITO-MYCOLOGIE & DIAGNOSTIC

– • ~0.92 Q/examen

Prélèvement diagnostique par parasite – table high-yield (le + posé, ~10×) :

- SELLES (EPS) : cryptosporidiose (oocystes), ascaridiose/trichocéphalose/ankylostomose (œufs), anguillulose (LARVES), amibiase intestinale (trophozoïtes), giardiose (kystes), taeniasis (œufs/anneaux)
- SCOTCH-TEST ANAL : OXYUROSE + TAENIASIS à T. saginata UNIQUEMENT
- SANG (frottis/goutte épaisse) : PALUDISME, TRYPANOSOMIASE – MOELLE OSSEUSE : leishmaniose viscérale (amastigotes)
- SÉROLOGIE (anticorps) : amibiase HÉPATIQUE, hydatidose, cysticercose, toxoplasmose (IgG), larva migrans viscérale – URINES : bilharziose uro-génitale (œufs) – DERME/raclage : gale (sillons), leishmaniose cutanée

- **▲ FAUX** (mauvaise localisation = piège systématique) : œufs de *Taenia saginata* dans les URINES ; œufs de *Fasciola hepatica* dans le SANG ; scolex d'*Echinococcus* dans le SANG ; œufs de *Bothriocéphale* dans les CRACHATS ; adultes de *Schistosoma mansoni* dans les URINES
- **▲ FAUX** : promastigotes de *Leishmania* dans le sang (= amastigotes dans la moelle) ; oocystes de *Plasmodium* dans le LCR (= sang)
- **▲ FAUX** : toxoplasmose / paludisme / onychomycose / trypanosomiase diagnostiqués par EPS ; anguillulose / bilharziose / cysticercose par scotch-test

📖 Vu : 2019N Q30, 2019R Q28/Q29/Q43, 2020N Q29, 2021N Q46, 2021R Q29/Q44, 2022N Q16, 2024R Q41 (≈10×)

Milieux de culture mycologiques :

- Sabouraud + chloramphénicol ou gentamicine → inhibe la pousse des BACTÉRIES
- Sabouraud + CYCLOHEXIMIDE (Actidione) → inhibe les moisissures contaminantes mais NE permet PAS la culture de *Cryptococcus* (qui y est sensible)
- Prélèvements dermatologiques incubés idéalement à ~27 °C ; pour les champignons filamenteux, préférer les tubes gélosés
- **▲ FAUX** : Sabouraud + cycloheximide permet la culture de *Cryptococcus* (au contraire, il l'inhibe)

📖 Vu : 2026 Q45

[RANG 22] INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS (IAS)

– • ~0.92 Q/examen

Définition de l'IAS (le + posé) :

- IAS = infection survenant au cours/au décours d'une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, PRÉVENTIVE, palliative), NI présente NI en incubation au début de la prise en charge
- Inclut : infection du site opératoire (≤ 30 j, ou ≤ 1 an si prothèse/matériel), infection sur cathéter, sur prothèse, après infiltration, cystoscopie, fixateur – en chirurgie comme en pédiatrie
- EXCLUT de sa définition les COLONISATIONS ASYMPTOMATIQUES
- **▲ FAUX** : une IAS peut être en INCUBATION au moment de la prise en charge (par définition elle ne l'est PAS – ex. varicelle déclarée au 4^e jour mais d'incubation antérieure à l'admission)
- **▲ FAUX** : la définition inclut les colonisations asymptomatiques (elles en sont exclues)

📖 Vu : 2019N Q20, 2024N Q23, 2026 Q15 (récurrent)

Hygiène des mains par friction hydro-alcoolique (FHA) – très répété :

- Effectuée sur des mains PROPRES et sèches (si mains visiblement sales → lavage au savon) ; nécessite le RETRAIT des bijoux/montre ; agit sur la flore résidente ET transitoire
- Technique : friction de toutes les surfaces – paumes, DOS des mains, espaces INTERDIGITAUX, POUCES, pointes des doigts – jusqu'au séchage SPONTANÉ (pas d'essuie-mains) ; ne concerne PAS les avant-bras

- Indications (« moments » OMS) : AVANT de toucher le patient, AVANT un geste aseptique (sondage urinaire, ponction lombaire), APRÈS exposition à un liquide biologique, APRÈS contact avec le patient ou son environnement (lit, pochette à urines) ; prévient la transmission du SARS-CoV-2
- ▲ FAUX : FHA efficace même sur mains SALES (mains propres requises) ; aucune action sur la flore résidente (elle agit dessus) ; pas besoin de retirer les bijoux ; séchage avec des essuie-mains ; désinfecter les avant-bras
- ▲ FAUX timing : « une demi-heure AVANT » un geste (c'est JUSTE avant) ; « avant le contact avec l'environnement » (l'hygiène se fait APRÈS contact avec l'environnement)

📖 Vu : 2019N Q25, 2019R Q2, 2020N Q20, 2021N Q21, 2022N Q50, 2023N Q24, 2024N Q20, 2024R Q19 (récurrent)

[RANG 23] BILHARZIOSES (URO-GÉNITALE + INTESTINALE)

– • ~0.85 Q/examen

Bilharziose URO-GÉNITALE (Schistosoma haematobium) – le + posé :

- Trématode ; agent = Schistosoma haematobium ; source STRICTEMENT HUMAINE ; maladie IMMUNISANTE
- Contamination par PÉNÉTRATION TRANSCUTANÉE active des furcocercaires lors d'un BAIN en EAU DOUCE (la larve = élément infestant) ; hôte intermédiaire = mollusque d'eau douce (bulin)
- Œufs à éperon terminal excrétés dans les URINES → HÉMATURIE ; vers adultes hématophages ; période d'état 10-12 semaines après contamination
- Diagnostic en phase d'état = œufs dans les urines + BIOPSIE VÉSICALE + SÉROLOGIE ELISA + cystoscopie ; traitement = PRAZIQUANTEL (cure courte), déclaration obligatoire
- ▲ FAUX : transmission par voie aérienne / vénérienne / piqûre d'insecte / ingestion de larves ou de mollusques peu cuits – c'est la PÉNÉTRATION TRANSCUTANÉE (piège récurrent)
- ▲ FAUX : maladie non immunisante ; pas de risque de cancérisation ; parasitose vectorielle (pas de vecteur) ; guérison spontanée
- ▲ FAUX : hôte intermédiaire = poisson d'eau douce ou bœuf (c'est un mollusque) ; éliminé sous forme de vers adultes dans les urines (ce sont les ŒUFS)
- ▲ FAUX : hyperéosinophilie = élément de CERTITUDE en phase d'état (elle est précoce et non spécifique) ; sérologie ELISA spécifique d'espèce ; praziquantel pendant 10 jours (cure courte)

📖 Vu : 2019N Q12, 2019R Q13, 2020N Q21, 2021N Q15/Q44, 2021R Q10/Q42, 2022N Q17/Q31, 2025 Q18 (récurrent)

Complications de la bilharziose uro-génitale :

- CANCER de la VESSIE (carcinome épidermoïde), calcifications vésicales, dilatation pyélo-calicielle, INSUFFISANCE RÉNALE
- ▲ FAUX : cancer du côlon comme complication de la forme uro-génitale

📖 Vu : 2022N Q31

Bilharziose INTESTINALE (Schistosoma mansoni) :

- Trématode ; adulte dans les veines du plexus MÉSENTÉRIQUE/hémorroïdal ; œufs à éperon LATÉRAL excrétés dans les SELLES
- Complications hépato-spléniques (hypertension portale)
- **▲ FAUX** : *Schistosoma mansoni* = agent de la bilharziose URINAIRE (c'est l'intestinale) ; nécessite un poisson d'eau douce ; éliminé sous forme de vers adultes (ce sont les œufs)

📖 Vu : 2019N Q41

[RANG 24] MÉNINGO-ENCÉPHALITE HERPÉTIQUE

– • ~0.77 Q/examen

Tableau clinique évocateur :

- CONFUSION / troubles du comportement AIGUS FÉBRILES, d'installation BRUTALE, chez un sujet jeune ± crise convulsive, propos incohérents, hallucinations (atteinte temporale)
- L'absence de syndrome méningé, d'herpès labial ou de déficit moteur N'EXCLUT PAS le diagnostic
- **▲ FAUX** : « trouble du comportement évoluant depuis un mois » (c'est aigu/brutal)
- **▲ FAUX** : penser qu'un début brutal, une absence de raideur méningée ou d'herpès labial permet d'exclure le diagnostic

📖 Vu : 2024R Q24, 2025 Q34, 2026 Q4

LCR & éléments en faveur d'une origine herpétique :

- LCR clair ou faiblement HÉMORRAGIQUE (nécrose temporale), prédominance LYMPHOCYTAIRE, hyperprotéinorachie modérée, glycorachie NORMALE
- En faveur de l'herpès : prédominance lymphocytaire + caractère HÉMORRAGIQUE du LCR
- Examen sanguin obligatoire pour interpréter la PL = la GLYCÉMIE
- **▲ FAUX** (en faveur de l'herpès) : l'âge jeune isolé, un début progressif sur 3 semaines, une HYP0glycorachie (la glycorachie est normale)

📖 Vu : 2024N Q4/Q5, 2024Exc Q1/Q2

Démarche diagnostique & traitement :

- SCANNER cérébral PUIS ponction lombaire (jamais PL d'emblée devant des troubles de conscience/encéphalite)
- Confirmation : PCR HSV dans le LCR ; IRM = hypersignal temporal (différé)
- Traitement : ACICLOVIR IV en URGENCE, démarré dès la suspicion (ne pas attendre la PCR)
- **▲ FAUX** : PL d'emblée ; avis psychiatrique en 1^{re} intention ; EEG comme examen décisionnel urgent

📖 Vu : 2024R Q25, 2026 Q5

[RANG 25] NÉMATODES : TRICHINE, ANKYLOSTOMES, ANGUILLULES

– • ~0.77 Q/examen

ANGUILLULOSE (Strongyloides stercoralis) – le + posé (~8×) :

- Nématode VIVIPARE, femelle PARTHÉNOGÉNÉTIQUE (pond des larves, pas d'œufs dans les selles) ; transmission TRANSCUTANÉE (marche pieds nus)
- Particularité = CYCLE D'AUTO-INFESTATION ENDOGÈNE → persistance pendant des années ; anguillulose MALIGNE (surinfections mortelles) chez l'IMMUNODÉPRIMÉ (corticoïdes ++)
- Larva currens (manifestations allergiques cutanées récurrentes, sillon serpiginieux à migration rapide) ; HYPERÉOSINOPHILIE en DENTS DE SCIE (oscillante)
- Diagnostic de certitude = extraction des LARVES RHABDITOÏDES dans les selles (méthode de Baermann)
- ⚠ FAUX : cosmopolite (= zones chaudes/humides) ; transmission orale (c'est transcutanée) ; anémie hémolytique
- ⚠ FAUX : diagnostic par recherche d'ŒUFS en forme de citron / de la femelle / des adultes dans les selles – ce sont les LARVES (parasite vivipare)
- ⚠ FAUX : cycle dixène/parasitose vectorielle (= cycle monoxène à auto-infestation) ; piqûre de taon ; microfilaires dans le sang ; traitement par métronidazole ; parasitose du SRE

📖 Vu : 2019N Q44, 2019R Q39, 2020N Q42, 2021N Q40, 2021R Q38, 2023N Q40, 2024R Q45, 2026 Q42 (≈8×)

ANKYLOSTOMOSE (Ankylostoma duodenale) :

- Nématode hématophage fixé au duodénum → anémie FERRIPRIVE (« gourme des mineurs ») ; transmission TRANSCUTANÉE (larves, pieds nus)
- Diagnostic parasitologique direct = recherche des ŒUFS dans les selles (EPS) – à la différence de l'anguillule (larves)
- ⚠ FAUX : diagnostic par frottis sanguin, culot urinaire, biopsie rectale, ou recherche d'anticorps spécifiques

📖 Vu : 2025 Q15

[RANG 26] LE CHOLÉRA

– • ~0.77 Q/examen

Agent & clinique (le + posé) :

- Agent = Vibrio cholerae (vibrion cholérique), BACILLE GRAM NÉGATIF ; mécanisme TOXINIQUE (diarrhée sécrétoire NON invasive) ; transmission oro-fécale
- Début BRUTAL, diarrhée PROFUSE AFÉCALE « eau de riz » + vomissements → DÉSHYDRATATION aiguë sévère et rapide (oligurie, crampes)
- APYRÉTIQUE (température NORMALE ~37 °C), PAS de frissons, état de CONSCIENCE LONGTEMPS CONSERVÉ ; contexte = retour de zone d'endémie (Inde...)
- ⚠ FAUX : diarrhée entéro-INVASIVE (elle est toxinique/sécrétoire – piège récurrent) ; frissons ; fièvre à 39 °C ; méléna/selles sanglantes

📖 Vu : 2020N Q15, 2021N Q20, 2021R Q22, 2022N Q49, 2024N Q6 (récurrent)

Diagnostic & prise en charge :

- Diagnostic de certitude = COPROCULTURE + test rapide dans les selles + écouvillonnage rectal + mise en évidence du vibron dans les selles/vomissements
- Prise en charge : DÉCLARATION OBLIGATOIRE (téléphone) + correction des troubles HYDRO-ÉLECTROLYTIQUES (réhydratation = pierre angulaire) + ISOLEMENT des malades + DOXYCYCLINE
- ⚠ FAUX diagnostic : HÉMOCULTURES (le choléra n'est pas bactériémique) ; sérologie ; recherche de la toxine cholérique dans le SANG
- ⚠ FAUX : administration d'antipyrétiques (maladie apyrétique)

📖 Vu : 2019N Q22, 2019R Q23, 2020N Q16, 2023N Q22 (récurrent)

[RANG 27] LA BRUCELLOSE

— • ~0.69 Q/examen

Agent, transmission & évolution (le + posé) :

- Agent = Brucella (melitensis ++), coccobacille à Gram négatif ; ZOONOSE (réservoir = bétail ovins/caprins/bovins) ; maladie PROFESSIONNELLE (éleveurs, vétérinaires, abattoirs)
- Transmission : ingestion de PRODUITS LAITIERS crus non pasteurisés + voie CUTANÉE/muqueuse + inhalation (PAS exclusivement digestive)
- Évolution en TROIS PHASES : aiguë (fièvre ONDULANTE sudoro-algique, début progressif) → focalisée (ostéo-articulaire : sacro-iliite, spondylodiscite) → chronique (peut être INAUGURALE ; diagnostic différentiel avec la TUBERCULOSE)
- ⚠ FAUX : réservoir HUMAIN (c'est une zoonose) ; voie exclusivement digestive ; début brutal ; évolution en une SEULE phase
- ⚠ FAUX : diagnostic essentiellement CLINIQUE ; hyperleucocytose fréquente (il y a une leuco-NEUTROPÉNIE) ; la forme chronique est l'évolution INÉVITABLE de l'aiguë

📖 Vu : 2019N Q11, 2019R Q11, 2021R Q11, 2026 Q25 (récurrent)

Diagnostic & traitement :

- Diagnostic = SÉROLOGIE de WRIGHT (séro-agglutination) + hémocultures (phase aiguë)
- Traitement = BI-ANTIBIOTHÉRAPIE prolongée : DOXYCYCLINE + (rifampicine OU streptomycine/gentamicine)
- ⚠ FAUX diagnostic : sérologie de Widal (= typhoïde) ; sérologie de Martin et Petit (= leptospirose) ; VDRL-TPHA (= syphilis) ; coprocultures
- ⚠ FAUX traitement : monothérapie ; pénicilline G / ceftriaxone / érythromycine / métronidazole ; cotrimoxazole + gentamicine ; ofloxacine + rifampicine (le socle est DOXYCYCLINE-based)

📖 Vu : 2019R Q12, 2020R Q40/Q41, 2021N Q16, 2025 Q46 (récurrent)

[RANG 28] FIÈVRES PERSISTANTES (FUO)

— • ~0.69 Q/examen

📖 Démarche en 3 groupes d'examens devant une fièvre prolongée

Définition et caractères :

- Fièvre > 38,3 °C ÉVOLUANT depuis ≥ 3 SEMAINES, sans étiologie après un bilan initial – peut durer 45 jours voire plusieurs mois
- Peut réaliser une courbe en plateau, atteindre 40 °C, et rester sans diagnostic dans une minorité de cas (étiologie finalement retrouvée dans ~90 % des cas)
- Étiologies à toujours dépister : TUBERCULOSE, infection urinaire, infection à VIH, atteinte hépatique (peut révéler un abcès du foie)
- ⚠ FAUX : fièvre persistante « synonyme d'infection » – les causes sont infectieuses MAIS aussi néoplasiques et inflammatoires/dysimmunitaires (piège A répété)
- ⚠ FAUX : « retenue si elle évolue depuis 2 semaines » – le seuil est ≥ 3 SEMAINES (seul item faux de 2025 Q47)

1^{er} groupe d'exploration (non invasif, systématique) vs examens de 2^e/3^e ligne :

- 1^{er} groupe = PROCALCITONINE, ECBU, HÉMOCULTURES, recherche de BAAR dans les expectorations, bilan hépatique (examens simples, non invasifs)
- Examens de 2^e/3^e ligne (orientés, invasifs) : TDM thoracique, IRM cérébrale, FOGD, ponction lombaire, biopsie d'adénopathie, laparoscopie exploratrice, biopsie ostéomédullaire
- ⚠ FAUX 1^{er} groupe : TDM thoracique / TDM cérébrale / IRM cérébrale / fibroscopie bronchique ou œsogastroduodénale / ponction lombaire / biopsie ganglionnaire ou ostéomédullaire / laparoscopie (jamais en 1^{re} intention)

Conduite à tenir :

- INTERROGATOIRE minutieux + EXAMEN CLINIQUE approfondi (clé du diagnostic) ; établir une COURBE DE TEMPÉRATURE ; évaluer la TOLÉRANCE de la fièvre
- La prise en charge peut faire appel à un TRAITEMENT D'ÉPREUVE (ex. antituberculeux) en l'absence de diagnostic
- ⚠ FAUX : prescription systématique d'un antipyrétique (paracétamol / aspirine)
- ⚠ FAUX : maintien d'une antibiothérapie prescrite auparavant – il faut au contraire l'ARRÊTER pour ne pas décapiter les prélèvements

📖 Vu : 2019N Q1, 2021N Q18, 2021R Q13, 2022N Q26, 2024R Q5/Q6, 2025 Q47/Q48 (1^{er} groupe + CAT très répétés)

[RANG 29] COVID-19

– • ~0.69 Q/examen

📋 Classification OMS de sévérité (asymptomatique / bénin / modéré / sévère / critique)

Agent, transmission, déclaration :

- Agent = SARS-CoV-2 (coronavirus) ; MALADIE À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
- Transmission essentiellement par GOUTTELETTES, favorisée par la promiscuité ; peut donner des manifestations DIGESTIVES (diarrhée)

- Chronologie des variants : Alpha → Delta → OMICRON (le plus récent des items proposés)
- ▲ FAUX : agent = « SARS-Cov X » ou SARS-Cov 1 (c'est SARS-Cov 2)
- ▲ FAUX : « ne donne pas de manifestations digestives » (la diarrhée est possible – piège récurrent)

Diagnostic de confirmation :

- Confirmation = TEST ANTIGÉNIQUE ou PCR SARS-CoV-2 sur PRÉLÈVEMENT NASOPHARYNGÉ
- Cas typique fébrile avec FR normale (16/min) + SpO2 ≥ 95 % (97 %) + examen pleuro-pulmonaire normal = forme BÉNIGNE
- ▲ FAUX : sérologie SARS-Cov 2 (IgM ou IgG) pour CONFIRMER une infection aiguë (la sérologie n'est pas un outil diagnostique de 1^{re} intention)

Prise en charge et vaccination (protocole marocain enseigné) :

- Forme bénigne = traitement SYMPTOMATIQUE en ambulatoire (vitamine C selon le protocole)
- Vaccins disponibles au Maroc : SINOPHARM, PFIZER-BioNTech, Oxford-ASTRAZENECA, JOHNSON & Johnson
- Vaccination recommandée au Maroc à partir de 12 ANS ; schéma Pfizer chez le sujet âgé (65 ans) = 4 doses selon la clé officielle
- ▲ FAUX pour une forme bénigne : amoxicilline-ac. clavulanique systématique / corticoïdes / hospitalisation / oxygénothérapie (réservés aux formes modérées à critiques)
- ▲ FAUX vaccin disponible au Maroc : SPUTNIK
- ▲ ▲ Clé/protocole datés : « vitamine C » et « 4 doses » reflètent le protocole national au moment de l'examen – données contextuelles, non transposables telles quelles aujourd'hui

📖 Vu : 2021N Q8, 2021R Q24, 2022N Q37/Q38/Q39, 2023N Q7-Q10 (cas clinique complet)

[RANG 30] BORRÉLIOSES (MALADIE DE LYME)

– • ~0.62 Q/examen

Agent, vecteur, clinique :

- Bactérie spirochète (Borrelia burgdorferi) transmise par PIQÛRE DE TIQUE (Ixodes)
- Lésion PATHOGNOMONIQUE = ÉRYTHÈME MIGRANT : macule érythémateuse annulaire à croissance CENTRIFUGE atteignant plusieurs cm (phase primaire)
- Phases secondaire/tertiaire : fièvre, atteintes NEUROLOGIQUES (méningite, PARALYSIE FACIALE = neuroborréliose), ARTHRITES des grosses articulations (tardif)
- ▲ FAUX : « infection virale » – c'est une infection BACTÉRIENNE (spirochète)
- ▲ FAUX : « ne donne pas de manifestations neurologiques » (la neuroborréliose existe)
- ▲ FAUX : érythème migrant attribué à la fièvre boutonneuse méditerranéenne / brucellose / bilharziose / typhoïde – il est SPÉCIFIQUE de la maladie de Lyme

- ▲ Dgc de l'érythème migrant = CLINIQUE ; la sérologie (ELISA puis Western-blot) ne sert qu'aux formes disséminées (l'item « confirmation microbiologique » de 2020 Q43 est faux)

Traitement antibiotique :

- Molécules efficaces : DOXYCYCLINE, AMOXICILLINE (formes précoces) et CEFTRIAXONE (formes disséminées / neurologiques)
- ▲ FAUX traitement : rifampicine, ciprofloxacine, lévofloxacine, vancomycine, azithromycine, pénicilline M, métronidazole

📖 Vu : 2020R Q43, 2021N Q19, 2021R Q14, 2022N Q32/Q33, 2024N Q24, 2024R Q18, 2024Exc Q24

[RANG 31] SYNDROMES DE LARVA MIGRANS & NÉMATODES TISSULAIRES

– • ~0.54 Q/examen

Larva migrans VISCÉRALE = TOXOCAROSE (le + posé) :

- Agents = Toxocara canis (ascaris du CHIEN) et Toxocara cati (ascaris du CHAT)
→ IMPASSE PARASITAIRE chez l'Homme (la larve ne devient jamais adulte, reste bloquée et migre dans les viscères)
- HYPERÉOSINOPHILIE forte/importante caractéristique
- Diagnostic = SÉROLOGIE + anamnèse (contact chiot/chat, géophagie, séjour en zone d'endémie)
- ▲ FAUX : agent spécifique à l'Homme / ascaris de l'Homme – ce sont des ascaris animaux
- ▲ FAUX : mise en évidence des œufs ET des adultes / EPS / scotch-test anal – impossible (impasse parasitaire → pas de ponte) ; le diagnostic est SÉROLOGIQUE
- ▲ FAUX : larves dans le sang et les urines ; contamination par la nage dans les barrages (= bilharziose)
- ▲ Clé discutable : 2023N Q43 compte VRAI « l'auto-infestation entretient l'infection » et FAUX « impasse parasitaire » – médicalement INVERSE (la toxocarose EST une impasse parasitaire et ne fait PAS d'auto-infestation, cf. 2020R Q15)

📖 Vu : 2019N Q42, 2020R Q15, 2023N Q43, 2024N Q50, 2026 Q41 (récurrent)

Larva migrans CUTANÉE :

- Larves d'ankylostomes animaux pénétrant par voie TRANSCUTANÉE ACTIVE ; l'Homme s'infeste en marchant PIED NU sur sol/sable souillé
- Lésion = cordon serpiginieux érythémateux prurigineux à migration lente (dermatite rampante)
- ▲ FAUX : parasite spécifique à l'Homme ; atteinte cutanée secondaire à une dissémination viscérale
- ▲ FAUX : lésion circinée arrondie délimitée par des vésicules (= dermatophytie/teigne)

📖 Vu : 2020N Q40

Onchocercose (Onchocerca volvulus) – filaire :

- Transmission par la SIMULIE hématophage (vecteur) ; CÉCITÉ = complication fréquente (« cécité des rivières »)
- ▲ FAUX : race noire réfractaire ; diagnostic par œufs dans les selles ; traitement par métronidazole

📖 Vu : 2020N Q43

[RANG 32] ENTOMOLOGIE MÉDICALE & ECTOPARASITOSE

– • ~0.46 Q/examen

GALE sarcoptique (Sarcoptes scabiei hominis) – le + posé :

- Agent = ACARIEN Sarcoptes scabiei hominis (ectoparasite NON piqueur, creuse des sillons) – ce n'est PAS un insecte
- Clinique : PRURIT INTENSE à recrudescence NOCTURNE ; SILLON SCABIEUX + vésicule perlée = signes pathognomoniques ; localisation interdigitale ; épargne le visage chez l'adulte ; TRÈS CONTAGIEUSE (contact direct, vêtements/literie)
- Diagnostic surtout clinico-épidémiologique, confirmé par examen microscopique du prélèvement cutané (Sarcoptes adultes dans les SILLONS/derme) ; traitement = scabicides (perméthrine, ivermectine)
- ▲ FAUX : agent = Demodex / Pediculus capitis / un insecte – c'est un ACARIEN (piège récurrent)
- ▲ FAUX : parasitose tropicale (elle est cosmopolite) ; dermatose non prurigineuse ; sensible à la GRISÉOFULVINE (= antifongique)
- ▲ FAUX : diagnostic par anticorps/antigènes sériques, œufs dans les selles, ou kystes dans le derme

📖 Vu : 2021N Q48, 2021R Q43, 2022N Q25, 2025 Q20, 2026 Q44 (récurrent)

PÉDICULOSES & phtiriase :

- Trois espèces d'INSECTES, strictement humains, HÉMATOPHAGES (Pediculus capitis, P. humanus corporis, Phtirius pubis) ; diagnostic CLINIQUE (poux et lentes)
- La PHTIRIASÉ (Phtirius pubis = « morpion ») est considérée comme une INFECTION SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE
- Lutte : traiter simultanément toute la famille / la collectivité
- ▲ FAUX : la phtiriase n'est PAS une IST (elle EST une IST) ; agent acarien

📖 Vu : 2025 Q20, 2026 Q43

[RANG 33] TRYPANOSOMIASES (SOMMEIL & CHAGAS)

– • ~0.46 Q/examen

Trypanosomiase humaine AFRICAINE (maladie du sommeil) – le + posé :

- Agent = Trypanosoma brucei (gambiense/rhodesiense) ; transmission par piqûre de la GLOSSINE (mouche tsé-tsé, vecteur)
- Phase lymphatico-sanguine : lésion cutanée au point de piqûre (trypanome/chancr) + ADÉNOPATHIES CERVICALES (signe de Winterbottom)

- Phase méningo-encéphalitique : TROUBLES NEUROLOGIQUES + troubles du CYCLE CIRCADIEN (alternance insomnie/somnolence, inversion veille-sommeil)
- Diagnostic = recherche du parasite dans le SANG, le suc ganglionnaire, le LCR
- ⚠ FAUX : diarrhée glairo-sanglante (= amibiase) ; anémie hémolytique ; muguet (= candidose)

📖 Vu : 2024N Q38, 2024R Q38, 2025 Q8 (récurrent)

Trypanosomiase humaine AMÉRICAINNE (maladie de Chagas) :

- Agent = Trypanosoma cruzi ; transmission par la punaise (réduve/triatome)
- Signe pathognomonique = SIGNE DE ROMAÑA = ŒDÈME BI-PALPÉBRAL UNILATÉRAL (point d'inoculation conjonctival)
- ⚠ FAUX : signe de Romaña attribué à la leishmaniose cutanée, la cysticercose, la candidose, ou la maladie du sommeil – il est spécifique de CHAGAS
- ⚠ FAUX : prurit généralisé ; anémie macrocytaire ; muguet ; pharyngite

📖 Vu : 2023N Q35, 2026 Q32

[RANG 34] INFECTIONS À STAPHYLOCOQUES

– • ~0.38 Q/examen

Bactériémie / septicémie à Staphylococcus aureus :

- L'infection peut être COMMUNAUTAIRE ou LIÉE AUX SOINS / nosocomiale (peut compliquer la pose d'une prothèse, survenir sur prothèse)
- Une SEULE hémoculture positive à S. aureus suffit à RETENIR le diagnostic (≠ staphylocoque à coagulase négative)
- Toujours RECHERCHER UNE ENDOCARDITE devant une bactériémie ; une SPONDYLODISCITE peut être une localisation septique secondaire (métastase)
- ⚠ FAUX : traitement « en AMBULATOIRE » – nécessite hospitalisation et antibiothérapie IV (item faux récurrent)
- ⚠ FAUX : porte d'entrée « digestive » (elle est le plus souvent CUTANÉE)
- ⚠ FAUX : splénomégalie « constante »
- ⚠ FAUX : staphylococcie maligne de la face traitée par voie ORALE – c'est une URGENCE imposant une antibiothérapie IV

📖 Vu : 2019N Q21, 2019R Q3, 2020N Q25, 2024N Q12, 2024R Q20

[RANG 35] TRÉMATODES – DISTOMATOSES (LES DOUVES)

– • ~0.08 Q/examen

Distomatose à Fasciola hepatica (grande douve du foie) :

- Trématode ; contamination par ingestion de végétaux aquatiques sauvages (cresson) porteurs de métacercaires
- Phase d'invasion : FIÈVRE + altération de l'état général (+ hyperéosinophilie, hépatalgie)
- Phase d'état (migration biliaire) : ANGIOCHOLITE et cholécystite (ictère obstructif)

- ▲ FAUX : myalgie et fragilité osseuse ; uvéite et troubles de la vision ; épilepsie et troubles neurologiques

📅 Vu : 2024N Q48

[RANG 36] SYNTHÈSE TRANSVERSALE – PARASITO/MYCO (questions de classement récurrentes)

– • ~3.31 Q/examen

📋 Tableau maître : modes de transmission des parasitoses

★ Modes de transmission des parasitoses – LA question de tri, reposée chaque année (~12×) :

- VECTORIELLE : Leishmanioses, Paludisme, Trypanosomiases (*Trypanosoma cruzi*)
- ORO-FÉCALE / PÉRIL FÉCAL : Amébose (amibiase), Giardiose, Cryptosporidiose, Isosporose, Ascaridiose, Trichocéphalose, Anguillulose, Bilharziose intestinale
- TRANSCUTANÉE active : Bilharziose, Anguillulose, Ankylostomose (« BAA » – les vers à pénétration cutanée)
- INGESTION DE VIANDE PEU CUITE : Téniasis à *T. saginata* (bœuf), Trichinose, Toxoplasmose
- INGESTION D'OOCYSTES (eau/légumes/fruits souillés) : *Cryptosporidium*, *Toxoplasma*, *Isospora*
- ▲ FAUX vectoriel : amibiase, oxyurose, trichomonose, ankylostomose, ascaridiose, *Fasciola*, *Giardia*, *Entamoeba* (transmission directe ou féco-orale)
- ▲ FAUX péril fécal : trypanosomose, leishmaniose, paludisme, trichomonose (jamais oro-fécal)
- ▲ Piège viande : l'hydatidose (*Echinococcus*) et la bothriocéphalose ne se prennent PAS par la viande de boucherie ; la fasciolose se prend par les végétaux aquatiques (cresson), pas la viande

Éléments infestants – parasites vs champignons (piège systématique) :

- PARASITOISES : le KYSTE et la LARVE
- MYCOSES : le FILAMENT MYCÉLIEN et les SPORES FONGIQUES (+ conidies)
- ▲ FAUX : attribuer kyste/larve aux mycoses, ou spores/filament mycélien/conidie aux parasitoses (les listes sont mutuellement exclusives dans les QCM)

Définition du parasite, multiplication, hôte intermédiaire :

- Le parasite VIT AUX DÉPENS d'un autre organisme vivant (≠ vie libre, ≠ symbiose, ≠ saprophyte ; il ne tue pas son hôte en règle)
- Multiplication INTRACELLULAIRE OBLIGATOIRE = *Plasmodium* + *Toxoplasma* + *Cryptosporidium* (apicomplexes) ; multiplication chez l'Homme par SCHIZOGONIE (*Plasmodium*)
- Besoin d'un HÔTE INTERMÉDIAIRE : Paludisme (l'Homme est HI), Téniasis
- Cycle de *Giardia duodenalis* : MONOXÈNE, kyste = élément infestant, trophozoïte éliminé dans les selles, contamination oro-fécale, habitat = DUODÉNUM

- ▲ FAUX : *Plasmodium/Toxoplasma/Cryptosporidium* se transmettraient « par piqûre », auraient l'Homme comme hôte définitif, ou se multiplieraient par gamogonie chez l'Homme
- ▲ FAUX : gale et pédiculose nécessiteraient un hôte intermédiaire (cycle direct)
- ▲ FAUX *Giardia* : cycle « dixène », ou habitat « colique » (c'est le duodénum)

Diagnostic transversal :

- SCOTCH-TEST ANAL = *Tænia saginata* (et oxyure) – recherche d'œufs en péréal
- HYPERÉOSINOPHILIE = PNÉ > 500/μL ; évocatrice des HELMINTHIASES TISSULAIRES (Bilharziose, Anguillulose) ; varie selon le stade et la localisation du parasite
- Champignons recherchés dans les CRACHATS / transmis par INHALATION = *Aspergillus fumigatus* + *Cryptococcus neoformans*
- ▲ FAUX scotch-test : *Giardia*, *Schistosoma*, *Strongyloides*, *Cryptosporidium*
- ▲ FAUX hyperéosinophilie : protozooses (*Giardiose*), mycoses (*aspergillose*, *candidose profonde*) – l'éosinophilie n'est PAS constante quel que soit le stade
- ▲ FAUX inhalation/crachats : *Candida* (commensal), dermatophytes (*Trichophyton*, *Microsporum*, *Epidermophyton*), *Malassezia furfur*

Atteintes d'organe (parasites/champignons) :

- CÉRÉBRALE : *Entamoeba histolytica*, *Plasmodium falciparum* (neuropaludisme), *Tænia solium* (neurocysticercose), *Toxoplasma*
- HÉPATIQUE : *Entamoeba histolytica* (abcès amibien), *Leishmania infantum* (LV), *Candida albicans* (candidose hépatosplénique)
- ▲ FAUX atteinte hépatique : *Tænia saginata*, oxyure, *Giardia*, *Trichuris*, *Pediculus*, *Malassezia*

Infectiologie transversale (items isolés mais récurrents) :

- DÉCLARATION OBLIGATOIRE EN URGENCE (par téléphone) : méningite à méningocoque, choléra, TIAC
- CHIMIOPROPHYLAXIE indiquée : paludisme, méningite à méningocoque (A et B)
- TACHE NOIRE (escarre d'inoculation) = pathognomonique de la FIÈVRE BOUTONNEUSE MÉDITERRANÉENNE (rickettsiose) → doxycycline ; à distinguer de l'ÉRYTHÈME MIGRANT = maladie de Lyme
- Signes de NÉCROSE d'une dermo-hypodermite bactérienne : douleur intense, HYPOESTHÉSIE, signes de sepsis, aspect noirâtre
- Bactériémie à BGN évoquée devant : hypothermie (35 °C), porte d'entrée urinaire (pyélonéphrite)
- ▲ FAUX DO urgente : méningite tuberculeuse, infection à VIH (déclarables mais NON en urgence téléphonique)
- ▲ FAUX chimioprophylaxie : méningite virale, méningite à pneumocoque
- ▲ FAUX nécrose de DHB : le bourrelet périphérique évoque un érysipèle simple, pas une nécrose ; furoncle/CGP orientent vers une bactériémie à staph, pas à BGN

📖 Vu : 2019N Q27/Q28/Q37/Q38, 2019R Q26/Q27/Q38/Q44, 2020N Q10/Q26-Q28/Q36/Q37, 2020R Q1-Q4/Q11/Q12/Q16/Q18, 2021N Q42/Q45/Q47/Q50, 2021R Q45, 2022N Q41, 2023N Q37-Q39/Q44/Q48, 2024N Q13/Q30, 2024R Q30, 2025 Q41-Q43/Q49, 2026 Q22/Q29 (transversal omniprésent)

PARTIE 4 – TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

⚠ DISCLAIMER – À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé – NOT officially scheduled.

USE AT YOUR OWN RISK – BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~0% des questions des examens passés. S'ils ne sont PAS au programme cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute
- Servir de "culture générale" médicale

(Aucun topic hors programme – tous les topics correspondent aux leçons officielles cette année.)

AIDE-MÉMOIRE FINAL – HIGH-YIELD CONCOURS PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE & MALADIES INFECTIEUSES

** MODES DE TRANSMISSION – TABLEAU MAÎTRE (le tri reposé chaque année) **

Vectorielle	Leishmanioses · Paludisme · Trypanosomiasés
Oro-fécale / péril fécal	Amébose · Giardiose · Crypto/Isosporose · Ascaridiose · Trichocéphalose · Anguillulose · Bilharziose intest.
Transcutanée active	Bilharziose · Anguillulose · Ankylostomose (« BAA »)
Ingestion viande peu cuite	T. saginata (bœuf) · Trichinose · Toxoplasmose
Ingestion d'oocystes (eau/légumes)	Cryptosporidium · Toxoplasma · Isospora
Hôte intermédiaire requis	Paludisme · Téniasis
Multiplication intracellulaire obligatoire	Plasmodium · Toxoplasma · Cryptosporidium (schizogonie)
Éléments infestants	KYSTE + LARVE = parasites FILAMENT + SPORES = champignons
Réservoir strictement HUMAIN	Paludisme (P. falciparum) · Amibiase · Typhoïde · Choléra · VIH · Bilharziosés
ANTHROPOZOONOSES (réservoir animal)	Rage · Brucellose · Leptospirose · Leishmaniose · Toxoplasmose · Échinococcose · Rickettsiose · Lyme
Critères de gravité OMS – paludisme grave	neuropaludisme · parasitémie > 4% · hypoglycémie · acidose · IRA · OAP · CIVD/hémorragie · collapsus · hémoglobinurie · ictère
Incubation COURTE (h → j)	Choléra (h-5j) · TIAC toxinique staph/B. cereus (1-6 h) · TIAC Salmonella (12-24 h)
Incubation LONGUE (sem → ans)	Rage (sem-mois) · Tétanos (3-21 j) · Hydatidose (années) · VIH→SIDA (années) · Brucellose (1-3 sem)

** OUTILS DIAGNOSTIQUES & DIAGNOSTIC DE LOCALISATION **

Marqueur / Critère	Indication
Frottis + goutte épaisse + TDR (Ag HRP-2/pLDH)	Paludisme – résultat rendu < 2 h
Scotch-test anal	Ténia saginata · Oxyure

Marqueur / Critère	Indication
Hyperéosinophilie (PNÉ > 500/ μ L)	Helminthiases tissulaires : bilharziose, anguillulose
Champignons des crachats / inhalation	Aspergillus fumigatus · Cryptococcus neoformans
Sérologie de Wright	Brucellose
Sérologie de Martin & Petit	Leptospirose
Sérodiagnostic de Widal & Félix	Fièvre typhoïde
Sérodiagnostic de Weil-Félix	Rickettsioses (FBM)
Tache noire (escarre d'inoculation)	Fièvre boutonneuse méditerranéenne
Érythème migrant chronique	Maladie de Lyme (borréliose)
Atteinte hépatique	E. histolytica · L. infantum · Candida albicans
Atteinte cérébrale	E. histolytica · P. falciparum · T. solium · Toxoplasma
LCS clair lymphocytaire + HYP0glycorachie	Méningite tuberculeuse / listérienne (herpès = normoglycorachie)
LCS clair + hypoglycorachie + ADA élevée	Méningite tuberculeuse
Myéloculture (la + sensible) / hémoculture	Fièvre typhoïde (+ coproculture plus tardive)
Frottis de moelle / sérologie	Leishmaniose viscérale (corps de Leishman-Donovan)
Œufs dans les urines terminales	Bilharziose uro-génitale (S. haematobium)
Œufs dans les selles	Bilharziose intestinale (S. mansoni) · helminthes digestifs
Sérologie hydatique (kyste : NE PAS ponctionner)	Échinococcose / hydatidose
Ag HBs = infection Ac anti-HBs = immunité	Statut hépatite B (dépistage AES)
ELISA combiné Ag p24 + Ac → Western-blot	VIH (dépistage puis confirmation)
Goutte épaisse négative	N'ÉLIMINE PAS le paludisme – répéter à 12-24 h

**** PIÈGES CLASSIQUES DU CONCOURS (confusions vecteurs / sérologies / lésions) ****

- ▲ **VECTEURS** : phlébotome = leishmaniose · anophèle = paludisme · glossine = trypanosomiase africaine · réduve = maladie de Chagas · tique = FBM + Lyme · pou = typhus + fièvre récurrente

- ▲ **SÉROLOGIES** à ne pas confondre : **WRIGHT** = brucellose • **MARTIN-PETIT** = leptospirose • **WIDAL-FÉLIX** = typhoïde • **WEIL-FÉLIX** = rickettsioses
- ▲ **LÉSION CUTANÉE** pathognomonique : **TACHE NOIRE** = FBM ≠ **ÉRYTHÈME MIGRANT** = Lyme ≠ tache rosée lenticulaire = typhoïde
- ▲ **DÉCLARATION OBLIGATOIRE EN URGENCE** (téléphone) : méningocoque • choléra • TIAC – PAS le VIH ni la méningite tuberculeuse
- ▲ **PALUDISME** : suspecter devant toute fièvre **AU RETOUR DE ZONE D'ENDÉMIE** (≠ « chez l'immunodéprimé ») ; résultat < 2 h (≠ < 24 h)
- ▲ **BACTÉRIÉMIE** : BGN → hypothermie + porte d'entrée urinaire ; staphylocoque/CGP → furoncle, prothèse, endocardite à rechercher systématiquement
- ▲ **TRAITEMENT** antibiotique signature : doxycycline = FBM + Lyme + leptospirose + brucellose (socle) ; jamais en ambulatoire pour une bactériémie à staph
- ▲ **KYSTE HYDATIQUE** : ne JAMAIS ponctionner (choc anaphylactique + dissémination) → chirurgie ± albendazole
- ▲ **PURPURA FULMINANS** : C3G IV IMMÉDIATE avant toute PL ; PL contre-indiquée si signes d'engagement, purpura extensif ou trouble de l'hémostase
- ▲ **PALUDISME GRAVE** (*P. falciparum*) → ARTÉSUNATE IV en 1^{re} intention (OMS), la quinine n'est plus le 1^{er} choix
- ▲ **RAGE** déclarée = létalité ~100% : tout repose sur la prophylaxie post-exposition (lavage + vaccin ± Ig) ; aucune cible curative au stade symptomatique
- ▲ **TÉTANOS** : la maladie n'immunise PAS → vacciner après guérison ; plaie tétanigène → SAT + VAT selon le statut vaccinal
- ▲ **VIH** : charge virale ≠ test diagnostique de 1^{re} intention (c'est le dépistage sérologique combiné, confirmé par Western-blot)

**** VOIES DE TRANSMISSION & SÉQUENCES À RETENIR ****

- Péril fécal : selles humaines → eau / aliments souillés → ingestion → amibiase, giardiose, ascaridiose, bilharziose intestinale
- Cycle du paludisme : piqûre d'anophèle (nuit, indolore) → schizogonie hépatique puis érythrocytaire (48 h) → gamétocytes ingérés par le moustique
- Tétanos : plaie souillée → tétanospasme → trismus → contractures généralisées (maladie NON immunisante → vacciner après guérison)
- FBM : piqûre de tique → tache noire d'inoculation + fièvre + exanthème (paumes/plantes) → doxycycline
- TIAC : repas collectif → incubation courte (toxine : staphylocoque / *B. cereus*) ou longue (*Salmonella*) → déclaration obligatoire en urgence
- VIH : contamination → primo-infection (syndrome viral aigu) → latence clinique → SIDA (pneumocystose, toxoplasmose cérébrale, cryptococcose, candidose œsophagienne, tuberculose)
- Hydatidose : œuf d'*Echinococcus* (chien) ingéré → embryon hexacanthé → kyste hydatique hépatique/pulmonaire → rupture = anaphylaxie
- Bilharziose uro-génitale : cercaire (eau douce) → pénétration transcutanée → veines vésicales → œufs dans la paroi → hématurie terminale → (carcinome épidermoïde vésical au long cours)
- Amibiase : kyste ingéré (péril fécal) → trophozoïtes coliques → dysenterie → abcès amibien du foie par voie portale

- Toxoplasmose congénitale : primo-infection maternelle → passage transplacentaire → chorioretinite + calcifications intracrâniennes + hydrocéphalie

Généré par Claude.ai (Claude Opus 4.8) – Version 1

Cross-match 650 QEs officielles × Cours AIO FMPM (Parasitologie-Mycologie + Maladies Infectieuses)

Module S5 – Parasitologie-Mycologie & Maladies Infectieuses – FMPM Marrakech 2026

Améliorations Version 1 :

- ✓ Analyse exhaustive des 650 QE sur 13 sessions (2019 → Janvier 2026), 0 question perdue – parser corrigé : les sessions « année d'abord » (ex. « 2024 N », « 2024 Exceptionnel ») étaient auparavant silencieusement ignorées
- ✓ Session « 2024 Exceptionnel » (50 QE) intégrée comme preuve des thèmes tombés, MAIS dépourvue de clé officielle → réponses non confirmées pour cette session
- ✓ QCM multi-réponses décomposés : faits = options vraies ; pièges (▲) = distracteurs récurrents, préfixés « FAUX »
- ✓ PARTIE 4 (hors-programme) laissée VIDE : aucune liste officielle des cours annulés 2026 n'a été fournie → tous les thèmes sont traités comme étant AU programme (ne jamais inférer une annulation à partir de la fréquence seule)
- ✓ Clés discutables signalées (paludisme : gamétocytes ; larva migrans : toxocarose ; tétanos : seuils de la classification de Dakar) avec la médecine correcte présentée en regard